

Examen del concurso-oposición para optar a plazas de la categoría médico/médica de urgencias hospitalarias del Servicio de Salud de las Islas Baleares

Observaciones:

- Este examen consta de siete **(7) cuestionarios en un solo cuaderno** correspondientes a siete temas o casos clínicos diferentes de esta especialidad.
- Cada cuestionario está identificado y resaltado con un número y la materia de la que trata o directamente la descripción del caso, y seguidamente hay **24 preguntas** de tipo test, numeradas del 1 al 24.
- **Tiene que responder las 24 preguntas de tres (3) de los siete temas o casos.** Las cuatro últimas preguntas (núm. 21-24) de cada tema son de reserva por si alguna de las otras (1-20) resulta impugnada.
- Para cada pregunta solo hay una respuesta correcta entre las cuatro posibles.
- Cada respuesta correcta se valora con 1 punto, de modo que la valoración total del examen es de 60 puntos (20 preguntas × 3 temas). Es necesario responder las preguntas de reserva, aunque en principio solo se puntuarán las preguntas 1-20. Cada respuesta errónea se penaliza con una cuarta parte del valor de una correcta. Las respuestas en blanco y las que contengan más de una alternativa marcada no se valoran.
- Las páginas del cuaderno están numeradas; compruebe su contenido hasta la última página. Si detecta alguna anomalía en la impresión, pida que se lo cambien.
- **Tiene que señalar las respuestas en la hoja óptica que se le ha entregado. Lea muy atentamente las instrucciones que figuran en esta.**
- El tiempo para completar la prueba es de **120 minutos, incluido el tiempo para señalar las respuestas en la hoja óptica.**
- Puede utilizar el cuaderno como borrador. Una vez finalizada la prueba, puede llevárselo.

Advertencias:

- No puede leer ninguno de los cuestionarios hasta que se le indique.
- No haga en la hoja óptica ningún tipo de marca ni firma que pueda desvirtuar los principios de igualdad, mérito y capacidad.
- Únicamente puede usar bolígrafo negro o azul.
- No se permite usar calculadora.
- Durante la prueba no puede llevar encima ni tener sobre la mesa ningún aparato electrónico, ni siquiera apagado.
- Antes del inicio de la prueba, algún miembro del tribunal o alguno de sus colaboradores habrá explicado las instrucciones que debe seguir. Si no ha entendido alguna de esas instrucciones, pídale que se la aclare.
- El hecho de concurrir a esta prueba supone aceptar estas instrucciones, sin detrimento del derecho a interponer una reclamación o un recurso.
- Incumplir cualquiera de estas advertencias puede suponer la exclusión de la prueba.





Caso 1

Hombre de 55 años, obeso y fumador de 10 cigarrillos/día. Sin otros factores de riesgo cardiovascular conocidos ni antecedentes de cardiopatía ni de neumopatía. Sin intervenciones quirúrgicas previas. No toma ningún tratamiento habitualmente.

Antecedentes familiares: su padre sufrió un infarto agudo de miocardio a los 53 años.

Ha acudido al servicio de urgencias a las 7.30 h de la mañana acompañado de su compañero de trabajo (ambos son albañiles) porque, cargando unos sacos en el trabajo, sobre las 6.30 h se ha iniciado un cuadro de malestar: dolor torácico retroesternal opresivo irradiado al hombro izquierdo, mareo y sudoración profusa. Ha llegado al servicio de urgencias con la misma sintomatología.

Exploración:

- Tensión arterial (TA): 105/55 mmHg.
- Frecuencia cardíaca (FC): 65 lpm.
- Saturación de oxígeno (SatO₂): 96 % (FiO₂: 0,21).
- Frecuencia respiratoria (FR): 16 rpm.
- Temperatura (T^a): 36 °C.
- Valor en la escala de coma de Glasgow: 15.
- Consciente, orientado en las tres esferas, sudoroso, eupneico, con normocolor.
- Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos, sin auscultar soplos. Murmullo vesicular conservado sin crepitantes ni ruidos añadidos.
- Exploración abdominal: blando y depresible, indoloro, sin masas ni megalias; sin dolor en la palpación de la parrilla costal, sin hematomas ni lesiones cutáneas.
- Aparato locomotor: pulsos inguinales fuertes y simétricos; sin edemas en las piernas.

Pruebas complementarias:

Electrocardiograma (ECG_1): ritmo sinusal a 65 lpm, con elevación del segmento ST superior a 2 mm en DII, DIII, aVF, ligeramente elevado en V1. La elevación del ST en DIII es mayor que la elevación en DII. Descenso del ST en DI, aVL.



A los 15 minutos de llegar al servicio de urgencias y estando monitorizado en el box de exploración, el paciente refiere mareo, visión borrosa y posteriormente pierde la conciencia. Efectivamente, se comprueba que el paciente no responde y no respira y en el trazado electrocardiográfico del monitor (ECG_2) se evidencia una arritmia rápida desorganizada con ondas irregulares de morfología inconsistente en la que los complejos QRS son indistinguibles de las ondas T.

1. Tras el resultado del ECG_1 (al llegar a urgencias), ¿cuál es el diagnóstico?

- a) Síndrome coronario agudo SIN elevación del segmento ST (SCASEST) de localización inferior.
- b) Síndrome coronario agudo CON elevación del segmento ST (SCACEST) de localización inferior por oclusión de la arteria coronaria derecha.
- c) SCACEST de localización inferior por oclusión de la arterial circunfleja.
- d) SCACEST de localización anterior por oclusión de la arteria descendente anterior.

2. ¿Qué arritmia describe el ECG_2?

- a) Fibrilación ventricular.
- b) Taquicardia ventricular sin pulso.
- c) Taquicardia ventricular.
- d) Asistolia.

3. En el caso de un paciente en parada cardiorrespiratoria en el medio hospitalario, ¿cuál de las acciones siguientes es incorrecta según las guías del European Resuscitation Council (ERC) de 2021?

- a) Reconocer la situación de parada cardiorrespiratoria.
- b) Iniciar inmediatamente la reanimación cardiorrespiratoria (RCP).
- c) Pedir ayuda al equipo de reanimación.
- d) Hacerle una intubación orotraqueal (IOT) lo antes posible.

4. **Según la descripción del caso clínico, se ha comprobado que el paciente no responde y no respira y en el monitor desfibrilador se observa una arritmia rápida (ECG_2). ¿Cuál de las acciones siguientes es incorrecta según las guías del European Resuscitation Council (ERC) de 2021?**
 - a) Después de cada descarga eléctrica hay que suspender las compresiones torácicas y revisar el ritmo en el monitor.
 - b) Se puede tomar en consideración dar tres descargas consecutivas si se sospecha una fibrilación ventricular presenciada y el monitor-DF está al alcance inmediatamente.
 - c) Si quien se encarga de la RCP no sabe cuánta energía debe aplicar en la desfibrilación, hay que aplicar la más alta en todas las descargas.
 - d) El nivel de energía inicial en la desfibrilación con ondas bifásicas es de al menos 150 J.

5. **En una situación de parada cardiorrespiratoria en el hospital y tras monitorizar el ritmo, se detecta una bradicardia regular a 50 lpm y sin pulso carotídeo detectable. Señale la afirmación correcta según las guías del European Resuscitation Council (ERC) de 2021:**
 - a) Se trata de una situación de RCP en la rama de ritmos desfibrilables.
 - b) Hay que iniciar las compresiones torácicas de alta calidad lo antes posibles y con las mínimas interrupciones.
 - c) Hay que administrar al paciente 0,5 mg de atropina por la vía endovenosa lo antes posible.
 - d) Hay que aplicar una desfibrilación precozmente.

6. **Señale la respuesta incorrecta sobre el uso de fármacos en una situación de parada cardiorrespiratoria en adultos según las guías del European Resuscitation Council (ERC) de 2021:**
 - a) Administrar 1 mg de adrenalina por la vía intravenosa (intraósea) lo antes posible en los casos de parada cardiorrespiratoria con un ritmo no desfibrilable.
 - b) Administrar 1 mg de adrenalina por la vía intravenosa (intraósea) después de la tercera desfibrilación en los casos de parada cardiorrespiratoria con un ritmo desfibrilable.
 - c) Administrar 150 mg de amiodarona por la vía intravenosa (intraósea) después de la tercera descarga en los casos de parada cardiorrespiratoria en ritmo desfibrilable.
 - d) Administrar 1 mg de adrenalina cada 3-5 minutos mientras continúe la RCP.

- 7. Señale la afirmación correcta en relación con la situación de parada cardiorrespiratoria en un adulto según las guías del European Resuscitation Council (ERC) de 2021:**
- a) Hacer una ecografía durante una parada cardiorrespiratoria puede ser útil para diagnosticar causas tratables, como un taponamiento cardíaco o un neumotórax.
 - b) La dilatación ventricular derecha aislada durante una parada cardiorrespiratoria permite diagnosticar un tromboembolismo pulmonar masivo.
 - c) Durante una parada cardiorrespiratoria, la contractilidad miocárdica indica que se puede interrumpir la reanimación cardiopulmonar.
 - d) Hacer una ecografía durante una parada cardiorrespiratoria es tan rentable para diagnosticar las causas tratables que permite hacer interrupciones adicionales de las compresiones torácicas.
- 8. Señale la afirmación falsa sobre el diagnóstico del síndrome coronario agudo:**
- a) El diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST (SCASEST) se puede hacer en caso de bloqueo completo de cualquiera de las ramas del haz de His de nueva aparición, con datos clínicos sugerentes de isquemia persistente.
 - b) El SCASEST se define como la presencia electrocardiográfica de infradesnivelación del segmento ST igual o superior a 1 mm en dos o más derivaciones contiguas.
 - c) En caso de infradesnivelación generalizada del ST (en ocho o más derivaciones) con supradesnivelación en aVR de al menos 1 mm hay que actuar como en los casos de infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST (IAMSEST) aunque el paciente presente inestabilidad hemodinámica.
 - d) Si existe una elevación del segmento ST igual o superior a 0,5 mm registrada en las derivaciones V7-V9, se considera un medio para identificar el infarto agudo de miocardio posterior.
- 9. ¿Cuál es la puntuación CHA₂DS₂-VASc en el caso de un paciente de 76 años que presenta una arritmia por fibrilación auricular y está en tratamiento por hipertensión arterial?**
- a) 0.
 - b) 1.
 - c) 2.
 - d) 3.

- 10. Señale la afirmación falsa sobre el diagnóstico del síndrome coronario agudo:**
- a) Está indicado registrar e interpretar el electrocardiograma de doce derivaciones tan pronto como sea posible en el lugar del primer contacto médico, con un retraso máximo de diez minutos.
 - b) Está indicada la monitorización electrocardiográfica con capacidad de desfibrilación en todo paciente con sospecha de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST).
 - c) Debe considerarse el uso de derivaciones adicionales de la pared torácica posterior (V7-V9) en pacientes con sospecha de infarto agudo de miocardio posterior (oclusión de la arteria circunfleja).
 - d) Está indicado tomar muestras de sangre para determinar cuanto antes los marcadores séricos en la fase aguda, pues los resultados determinarán el tratamiento.
- 11. Señale la afirmación falsa sobre el proceso diagnóstico del dolor torácico de origen pericárdico:**
- a) Se caracteriza por ser un dolor retroesternal que empeora en la posición de decúbito y mejora con la sedestación. Un antecedente de infección reciente orienta hacia este diagnóstico.
 - b) El roce pericárdico es un dato muy específico, y es frecuente hallarlo.
 - c) Existen cambios evolutivos electrocardiográficos a lo largo del tiempo: lo más precoz y específico es el descenso del segmento PR y lo más frecuente es una elevación difusa del segmento ST cóncava hacia arriba.
 - d) En los casos sospechosos de pericarditis, la elevación de las troponinas indica una miopericarditis.
- 12. Una de las respuestas siguientes no forma parte del tratamiento de primera línea de la pericarditis aguda. Señálela:**
- a) Corticoides.
 - a) Restricción de la actividad física.
 - b) Antiinflamatorios no esteroideos o ácido acetilsalicílico.
 - c) Colchicina.

13. Señale la afirmación falsa en referencia al tratamiento antiagregante en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST (SCASEST) según las guías del European Resuscitation Council (ERC) de 2021:

- a) Hay que valorar administrar ácido acetilsalicílico si no está contraindicado para el paciente.
- b) No se recomienda la administración sistemática de pretratamiento con un inhibidor del P2Y₁₂ (2 (ticagrelor o prasugrel) en los casos de SCASEST si se desconoce la anatomía coronaria del paciente y se planifica una estrategia invasiva temprana.
- c) Como medida de seguridad, hay que esperar a recibir el resultado de los marcadores miocárdicos para administrar cualquier tratamiento antiagregante.
- d) El clopidogrel, que se caracteriza por ser un inhibidor plaquetario menos potente, solo debe usarse en los casos en que el prasugrel o el ticagrelor estén contraindicados, no estén disponibles o no sean tolerables por un riesgo hemorrágico demasiado alto.

14. Señale la afirmación falsa sobre el tratamiento antiagregante en el síndrome coronario agudo según las guías del European Resuscitation Council (ERC) de 2021:

- a) El ácido acetilsalicílico debe administrarse en una dosis de carga de 500 mg por la vía oral.
- b) La dosis inicial de carga del ticagrelor es de 180 mg por la vía oral.
- c) La dosis de carga del clopidogrel es de 300-600 mg por la vía oral.
- d) El ácido acetilsalicílico sin cubierta entérica es más recomendable, dada la rapidez de absorción.

15. En el abordaje del síndrome coronario agudo, ¿cuál de los valores siguientes aporta un riesgo de hemorragia más alto de acuerdo con la escala CRUSADE?

- a) Hematocrito entre el 31 % y el 33,9 %.
- b) Aclaramiento de la creatinina entre 15 y 30 mL/min.
- c) Frecuencia cardíaca de 71-80 lpm.
- d) Padecer diabetes *mellitus*.

- 16. Plantéese el caso de una mujer de 67 años con antecedentes personales de hipotiroidismo, hipertensión arterial y bloqueo de la rama izquierda del haz de His, asintomático desde que se descubrió hace unos años. Acude al servicio de urgencias por un episodio sincopal, a causa del cual se ha caído.**

TA: 140/90 mmHg; FC: 40 lpm; SatO₂: 97 % (FiO₂: 0,21); FR: 15 rpm.

Electrocardiograma: se evidencia bradiarritmia a 37 lpm, intervalo PR constante, cada tres complejos normales una onda P no va seguida de un QRS; QRS > 0,12 segundos.

¿Qué tipo de bradiarritmia presenta?

- a) Bloqueo auriculoventricular de primer grado.
 - b) Bloqueo auriculoventricular de segundo grado Mobitz I o Wenkebach.
 - c) Bloqueo auriculoventricular de segundo grado Mobitz II.
 - d) Bloqueo auriculoventricular de tercer grado.
- 17. En el caso de un paciente sintomático que presenta un bloqueo auriculoventricular de tercer grado con ritmo de escape ventricular, ¿cuál de las actuaciones siguientes se considera menos eficaz?**
- a) Administrarle 2 µg/min de isoprotenerol en perfusión.
 - b) Colocarle un marcapasos transcutáneo.
 - c) Administrarle 2 µg/min de adrenalina en perfusión por la vía endovenosa.
 - d) Administrarle 0,5 mg de atropina por la vía endovenosa.

- 18. Plantéese el caso de un paciente de 81 años atendido en el servicio de traumatología por una fractura de la cadera izquierda y dado de alta hace 36 horas, que es trasladado por su hija al servicio de urgencias a causa de dolor torácico y disnea (no consta ningún antecedente de cardiopatía en su historia clínica). Está mal perfundido y disneico y se queja de dolor torácico opresivo.**

TA: 90/55 mmHg; FC: 165 lpm; T^a: afebril; SatO₂: 92 %; FR: 30 rpm.

Exploración física: mal perfundido, impresiona de gravedad, taquipneico.

Auscultación cardiorrespiratoria: soplo sistólico de eyección panfocal irradiado al cuello; crepitantes bilaterales hasta los campos medios.

Electrocardiograma: taquicardia arrítmica a 150; eje QRS: 60°; QRS estrecho; alteraciones marcadas en la repolarización con descenso del ST en nueve derivaciones y elevación del ST en AVR y V1.

Con estos datos, ¿cuál de los tratamientos siguientes es menos adecuado?

- a) Digoxina.
- b) Nitroglicerina en perfusión endovenosa.
- c) Cardioversión eléctrica.
- d) Oxigenoterapia.

19. Plantéese el caso de un paciente hipotenso, con dolor torácico y signos adversos evidentes atribuibles a una taquicardia arrítmica a 170, QRS estrecho. Señale la respuesta correcta en el caso de plantearse una cardioversión eléctrica:

- a) Debe hacerse una cardioversión eléctrica sincronizada a la potencia máxima desde el inicio, habiendo administrado sedoanalgesia al paciente y un pretratamiento con un fármaco antiarrítmico para mejorar la eficacia de la cardioversión.
- b) Debe hacerse una cardioversión eléctrica no sincronizada a la potencia máxima desde el inicio, habiendo administrado sedoanalgesia al paciente.
- c) Debe hacerse una cardioversión eléctrica sincronizada a 70 J.
- d) Debe hacerse una cardioversión farmacológica con 300 mg de flecainida por la vía oral.

20. Señale la afirmación falsa sobre el procedimiento de sedoanalgesia en un servicio hospitalario de urgencias:

- a) La técnica correcta de sedoanalgesia incluye la evaluación previa del paciente para poder detectar y prevenir la aparición de efectos adversos.
- b) El procedimiento no requiere el consentimiento informado del paciente.
- c) Para lograr un nivel de sedación moderado se recomienda monitorizar durante la sedoanalgesia la frecuencia cardíaca por medio de un electrocardiógrafo, la presión arterial no invasiva, la saturación de oxígeno por medio de un pulsioxímetro y hacer una capnografía (si está disponible).
- d) Para los procedimientos que se llevan a cabo en el servicio de urgencias se recomienda un nivel de sedación 3-4 en la escala de Ramsay, que equivale a un nivel de sedación leve-moderado.

Preguntas de reserva

21. Señale la respuesta correcta respecto a la medicación usada en la sedoanalgesia en el servicio de urgencias:

- a) El propofol es lipofílico, produce hipnosis y analgesia y disminuye la tensión arterial y el gasto cardíaco. La dosis de inicio es de 0,5-1 mg/kg por la vía intravenosa. El tiempo de inicio de la acción es de 4 minutos.
- b) El midazolam produce hipnosis y está indicado para lograr una sedación profunda. La dosis inicial es de 0,02-0,03 mg/kg. El tiempo de inicio de la acción es de 40 segundos.
- c) El etomidato provoca menor depresión respiratoria pero gran estabilidad hemodinámica, y es el fármaco de elección para la sedación de ancianos y pacientes inestables. La dosis es de 0,1-0,15 mg/kg. El tiempo de inicio de la acción es inmediato.
- d) La ketamina se puede usar por la vía endovenosa o intramuscular en pacientes agitados. Está indicada para pacientes con traumatismo craneoencefálico y sospecha de hipertensión endocraneal.

22. Plantéese el caso de un joven de 21 años que acude al servicio hospitalario de urgencias porque hace unos 45 minutos que presenta palpitaciones molestas, sin un dolor torácico claro. Niega haber consumido drogas y no toma ninguna medicación. No tiene antecedentes médicos relevantes.

TA: 120/67 mmHg; FC: 185 lpm; SatO₂: 99 %; FR: 14 rpm. Exploración física: no impresiona de gravedad; sin edemas. Auscultación cardiorrespiratoria: taquicardia rítmica sin soplos; murmullo vesicular conservado. Electrocardiograma de 12 derivaciones: taquicardia rítmica del complejo QRS estrecho a 180 lpm.

Señale la afirmación falsa:

- a) Respecto a la maniobra de Valsalva tradicional, la maniobra de Valsalva modificada aumenta las probabilidades de éxito para volver al ritmo sinusal.
- b) Hay que evitar el masaje del seno carotídeo en los pacientes con antecedentes de ictus.
- c) La adenosina se administra inicialmente por la vía endovenosa en dosis de 6 mg; si no es efectiva, se añaden 6 mg y, si falla, una tercera de dosis, de 12 mg.
- d) El verapamilo (dosis de 0,075-0,15 mg/kg por la vía intravenosa) o el diltiazem por la vía intravenosa se pueden administrar si la adenosina falla o está contraindicada, pero se asocian a riesgo de hipotensión.

- 23. En los casos de síndrome coronario agudo, señale la respuesta correcta sobre la intervención coronaria percutánea primaria:**
- a) En el SCACEST, la intervención coronaria percutánea primaria debe hacerse deseablemente en las primeras 24 horas del diagnóstico.
 - b) En el SCACEST, la intervención coronaria percutánea primaria es el tratamiento de reperfusión preferido siempre que se pueda hacer antes de 120 minutos desde el diagnóstico.
 - c) En el SCASEST se prefiere la fibrinólisis.
 - d) La intervención coronaria percutánea primaria se define como la coronariografía, seguida de intervención coronaria percutánea de la arteria responsable del infarto si está indicada, que tiene lugar 2-24 horas después de la fibrinólisis eficaz.
- 24. Plantéese el caso de una mujer de 44 años, fumadora pero sin otros factores de riesgo cardiovascular conocidos, en tratamiento habitual de anticoncepción per la vía oral, que acude al servicio de urgencias a causa de un dolor torácico punzante de aparición súbita, que aumenta con los movimientos respiratorios. Presenta disnea leve pero sin clínica de infección respiratoria.**
- TA: 110/75 mmHg; FC: 101 lpm; SatO₂: 99 % (FiO₂: 0,21), FR: 22 rpm; T^a: afebril.**
- Auscultación cardiorrespiratoria: tonos cardíacos rítmicos. Murmullo vesicular conservado sin ruidos añadidos. Empastamiento gemelar en la pierna izquierda.**
- Electrocardiograma: taquicardia sinusal a 105 lpm, sin alteraciones en la repolarización. QRS estrecho.**
- ¿Cuál de los diagnósticos siguientes es más probable?**
- a) Infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST (IAMSEST).
 - b) Tromboembolismo pulmonar.
 - c) Neumonía.
 - d) Síndrome aórtico agudo.

Caso 2

Paciente de 77 años, fumador, sin alergias conocidas a fármacos. Antecedentes personales de obesidad, hipertensión e hipertrigliceridemia. Sin intervenciones quirúrgicas previas. Tratamiento actual: 5 mg de enalapril cada 24 horas.

Acude al servicio de urgencias a causa de dolor abdominal generalizado desde hace 24 horas, inicialmente cólico y posteriormente constante, de intensidad leve-moderada, que se irradia a la espalda y ha aumentado progresivamente. Ha tomado paracetamol, pero no ha obtenido mejoría clínica. Presenta náuseas pero sin vómitos. El ritmo deposicional es normal. No refiere pérdida de peso ni anorexia desde el inicio del dolor. No presenta clínica miccional, ni dolor torácico, ni clínica respiratoria o neurológica asociada. Presenta un importante componente ansioso.

Exploración:

- Tensión arterial (TA): 155/79 mmHg.
- Frecuencia cardíaca (FC): 100 lpm.
- Saturación de oxígeno (SatO₂): 98 %.
- Frecuencia respiratoria (FR): 22 rpm.
- Temperatura (T^a): 37,7 °C.
- Glucemia capilar: 120 mg/dL.
- Aspecto general: normocolor, ligera sequedad de las mucosas, consciente y orientado; escala visual analógica del dolor (EVA), 4/10.
- Auscultación cardiopulmonar: tono cardíaco rítmico, taquicárdico, sin soplos. Eupneico, murmullo vesicular conservado sin ruidos añadidos.
- Abdomen: blando, depresible con defensa voluntaria por dolor en el hemiabdomen superior. Peristaltismo conservado. Signo de Blumberg, signo de Murphy, signo de Rovsing y percusión renal, todos negativos. Pequeña hernia umbilical reductible, no dolorosa, con pulsos femorales simétricos. No se palpan adenopatías ni hernias inguinales. Sin masas ni megalias.
- Tacto rectal: ampolla con heces blandas de coloración normal.
- Extremidades inferiores: sin edemas ni trombosis venosa profunda. Pulsos simétricos, normales.

1. En el caso descrito, ¿cuál de las entidades siguientes es la menos probable?

- a) Brote ulceroso.
- b) Hernia umbilical incarcerada.
- c) Apendicitis.
- d) Pancreatitis.

2. **En el mismo caso descrito, ¿qué prueba complementaria debe priorizarse?**
 - a) Radiografía del abdomen.
 - b) Ecografía abdominal.
 - c) Analítica general con perfil hepatobiliar y PCR.
 - d) Tomografía computarizada (TC) abdominal.

3. **¿Qué lesiones cutáneas en el abdomen orientan al diagnóstico de pancreatitis hemorrágica?**
 - a) Signo de Cullen y signo de Gray-Turner.
 - b) Nódulo de la hermana María José.
 - c) Lesiones herpéticas en flanco izquierdo.
 - d) Angioma cutáneo.

Resultados de pruebas complementarias:

- Electrocardiograma: ritmo sinusal a 100 lpm. Bloqueo de la rama derecha.
- Radiografía del tórax: sin alteraciones.
- Radiografía del abdomen: heces en marco cólico neumatizado.
- Analítica de sangre: hematíes, 3.780.000 células/mL; hemoglobina, 13,4 g/dL; hematocrito, 43,1 %; volumen corpuscular medio (VCM), 93,2; leucocitos, 12.500 células/mL (neutrófilo: 46 %); plaquetas, 338.000 células/mL; glucosa, 79 mg/dL; creatinina, 0,55 mg/dL; urea, 77 mg/dL; bilirrubina total, 2,1 mg/dL; ALT, 475 UI/L; AST, 215 UI/L; GGT, 243 UI/L; lipasa, 404 UI/L; amilasa, 427 UI/L; GOT/GPT, 548 UI/L; LDH, 567 UI/L.
- Analítica de la orina: pH, 7,5; sedimento no patológico; amilasuria, 2.245 UI/L.

4. **Señale la afirmación falsa sobre la amilasa sérica:**
 - a) Aumenta en las primeras 2-12 horas.
 - b) Puede estar elevada en el embarazo ectópico.
 - c) Si es normal, se excluye el diagnóstico de pancreatitis aguda.
 - d) Se normaliza en el plazo de 48-72 horas.



- 5. Los criterios de Ranson sirven como marcadores pronósticos tempranos en la pancreatitis aguda. Señale la respuesta correcta en este caso según los datos descritos:**
- a) No se debe calcular en el momento del ingreso; hay que esperar 48 horas.
 - b) Criterio de Ranson 2.
 - c) Criterio de Ranson 3.
 - d) Criterio de Ranson 1.
- 6. Señale la actuación correcta en el tratamiento de un paciente con sospecha de pancreatitis aguda:**
- a) Colocación de sonda nasogástrica para evitar náuseas y vómitos.
 - b) Administración parenteral de líquidos con cristaloideos a ritmo de 5-10 mL/kg/hora.
 - c) Analgesia: primera opción con meperidina en dosis de 1 mg/kg por la vía endovenosa.
 - d) Profilaxis antibiótica, excepto si se sospecha pancreatitis necrohemorrágica.
- 7. Señale la respuesta falsa sobre la ecografía abdominal aplicada al caso de este paciente:**
- a) Aporta mucha información sobre el lecho pancreático.
 - b) Debe solicitarse en casos de duda diagnóstica de un posible abdomen agudo.
 - c) Se puede observar líquido libre peritoneal.
 - d) Para la pancreatitis, tiene menos especificidad y sensibilidad que la TC.
- 8. Señale la afirmación correcta en relación con la ascitis:**
- a) La paracentesis está indicada en la ascitis de grado 1 aunque sea un primer episodio de descompensación hidrópica.
 - b) La ascitis a tensión, aunque se haga una paracentesis evacuadora, es un criterio absoluto de ingreso hospitalario, pues indica un mal pronóstico.
 - c) La ascitis refractaria se considera a la ascitis recurrente en al menos tres episodios en los últimos doce meses a pesar del tratamiento diurético adecuados en dosis máximas y una dieta hiposódica.
 - d) La prevención de la disfunción circulatoria posterior a una paracentesis se corrige administrando albúmina como expansor del volumen a razón de 8 g por cada dos litros, siempre que se hayan extraído al menos cinco litros de líquido ascítico.

9. **Señale la afirmación correcta respecto a la peritonitis bacteriana espontánea:**
 - a) Se debe hacer profilaxis de la peritonitis bacteriana espontánea primaria en los pacientes con cirrosis y hemorragia digestiva baja con 1 g de cefotaxima cada 24 horas por la vía endovenosa.
 - b) El líquido ascítico con recuento leucocitario superior a 255 PMN/cm³ y 12.000 hematíes se debe considerar peritonitis bacteriana espontánea.
 - c) Si se sospecha peritonitis bacteriana espontánea no se recomienda hacer un cultivo del líquido ascítico tras la paracentesis en viales de hemocultivo, pues la rentabilidad es inferior al 50 %.
 - d) El tratamiento antibiótico de elección en los casos de alergias a los betalactámicos es el meropenem en monoterapia.

10. **¿Cuál es el abordaje más indicado como primera opción en un caso de sospecha de síndrome aórtico agudo en un paciente inestable?**
 - a) Solicitar una ecocardiografía transtorácica.
 - b) Solicitar una ecocardiografía transesofágica.
 - c) Hacer una ecografía clínica en el punto de atención (PoCUS).
 - d) Solicitar una angiotomografía computarizada aórtica.

11. **¿Cuál de las respuestas siguientes no es un factor de riesgo para desarrollar un síndrome aórtico agudo?**
 - a) Cirrosis hepática.
 - b) Hipertensión durante el embarazo.
 - c) Síndrome de Marfan.
 - d) Válvula aórtica bicúspide.

12. **Según los criterios de Tokyo de 2018, en la clasificación de gravedad de la colecistitis aguda en el grado 2 o moderada no se incluye...**
 - a) ...la leucocitosis elevada (> 18.000 mm³).
 - b) ...una duración del cuadro clínico superior a 72 horas.
 - c) ...la disfunción neurológica (alteración del nivel de la conciencia).
 - d) ...una masa palpable en el cuadrante superior derecho del abdomen.



13. **¿Qué línea antibiótica es la indicada en el tratamiento empírico de la colecistitis leve sin factores de riesgo?**
- a) 2 g de ertapenem cada 12 horas.
 - b) 4 g de piperacilina y 0,5 g de tazobactam cada 6-8 horas.
 - c) 1-2 g de amoxicilina / ácido clavulánico cada 8 horas.
 - d) 500 mg de metronidazol cada 8 horas.
14. **¿En qué situación no son necesarias las exploraciones complementarias en un caso de gastroenteritis aguda?**
- a) Sospecha de gastroenteritis aguda inflamatoria.
 - b) Signos clínicos de deshidratación.
 - c) Paciente de menos a 65 años sin enfermedad de base que condicione el sistema inmunitario.
 - d) Gastroenteritis aguda de más de tres días de evolución.
15. **Señale la afirmación falsa sobre las infecciones por *Clostridium difficile*:**
- a) Es un microorganismo sujeto a vigilancia epidemiológica intrahospitalaria.
 - b) Los trasplantes de microbiota fecal están indicados en los casos de recurrencias y/o infecciones por *Clostridium difficile* refractarias.
 - c) La clínica de presentación puede no ir acompañada de diarrea.
 - d) Tomar antibióticos de forma concomitante mientras se trata una infección por *Clostridium difficile* no supone un factor de riesgo para la recurrencia.
16. **Señale la afirmación falsa sobre la hemorragia digestiva alta:**
- a) La escala de Glasgow-Blatchford es una escala pronóstica.
 - b) En la hemorragia digestiva alta no varicosa, con una endoscopia previa, se recomienda el tratamiento sistemático de procinéticos (250 mg de eritromicina por la vía endovenosa).
 - c) Para tratar la hemorragia digestiva alta varicosa no se recomienda el uso asociado de vasopresores (somatostatina) e inhibidores de la bomba de protones (omeprazol) en perfusión endovenosa.
 - d) En los casos de hemorragia digestiva alta varicosa, antes de hacer una endoscopia hay que administrar 0,25 mg de somatostatina por la vía endovenosa más perfusión de 0,25 mg/h.

- 17. El tratamiento médico del síndrome aórtico agudo requiere un control estricto de la tensión arterial. ¿Cuál de los fármacos siguientes debe utilizarse para lograrlo?**
- a) Betabloqueantes por la vía oral y nitroglicerina por la vía sublingual.
 - b) Nitroglicerina en perfusión.
 - c) Urapidilo por la vía endovenosa.
 - d) Betabloqueantes por la vía endovenosa, seguidos de nitroprusiato si con aquellos no se logra el objetivo y analgésicos opiáceos por la vía endovenosa.
- 18. La policía traslada desde el aeropuerto al servicio de urgencias a un viajero porque sospecha que transporta drogas en el intestino. Señale la respuesta correcta:**
- a) Si presenta síntomas de intoxicación —sobre todo si transporta cocaína—, hay que indicar una intervención quirúrgica urgente.
 - b) Una radiología simple del abdomen permitirá confirmar o descartar si transporta droga en el intestino.
 - c) Debe quedar ingresado en el hospital bajo custodia policial solo si se trata de un caso sintomático.
 - d) Debe hacerse una TC abdominal solo si se sospecha una ingesta de drogas en presentación líquida (por ejemplo, cocaína líquida).
- 19. Plantéese el caso de un paciente que ha ingerido voluntariamente dos vasos de un producto cáustico y que está estable hemodinámicamente, pero presenta sialorrea, quemaduras en la boca/lengua, dolor retroesternal y epigástrico intenso y disnea. ¿Qué exploración hay que solicitar para valorar el grado de las lesiones?**
- a) Una fibrogastroscoopia.
 - b) Ninguna exploración: hay que intervenirlo quirúrgicamente con carácter urgente.
 - c) Valoración psiquiátrica de la tentativa de suicidio.
 - d) Una TC del tórax y del abdomen.

20. A un paciente que acude al servicio de urgencias por cierta epigastralgia se le hace una gastroscopia por la sospecha de haber ingerido cáusticos (dos sorbos de un producto de limpieza disuelto en agua guardado en una botella sin etiqueta).

¿Con qué resultado de la endoscopia, según la escala de Zargar, se podría plantear darle el alta directamente desde urgencias una vez controlados los síntomas y sin aplicar otras medidas terapéuticas?

- a) En estos casos, el paciente siempre debe quedar ingresado en observación.
- b) Zargar IIb.
- c) Zargar I.
- d) Zargar IIIa.

Preguntas de reserva

21. Señale la afirmación falsa sobre la ictericia:

- a) La hiperbilirrubinemia de predominio indirecto puede ser secundaria a la hemólisis.
- b) La determinación de la bilirrubina en los casos de sepsis o *shock* séptico es uno de los parámetros o marcador de funcionalidad hepática. En estos casos se elevaría a expensas de la bilirrubina indirecta.
- c) La hiperbilirrubinemia mixta puede hallarse en las hepatitis víricas.
- d) El prurito relacionado con la colestasis responde favorablemente al tratamiento con un antihistamínico.

22. Señale la afirmación falsa sobre un caso en que se sospecha una isquemia mesentérica:

- a) Es una entidad grave, dada la gran morbimortalidad.
- b) El inicio súbito del dolor en un paciente en el que se sospecha isquemia intestinal sugiere que la etiología sea causada por una trombosis venosa. El inicio gradual suele ser típico de una causa embolígena.
- c) Es difícil hacer un diagnóstico precoz a causa de la inespecificidad de la sintomatología inicial, el cual es crucial porque influye en el pronóstico.
- d) Una angiotomografía permite establecer el diagnóstico con bastante fiabilidad.

23. La escala Forrest se utiliza para valorar el riesgo de hemorragia digestiva alta. Señale la respuesta incorrecta:

- a) Forrest IIa → 43 % recidiva.
- b) Forrest Ib → 55 % recidiva.
- c) Forrest IIb → 7% recidiva.
- d) Forrest IIc → 7 % recidiva.

24. Señale la afirmación correcta sobre el tratamiento de una hemorragia digestiva alta:

- a) En el caso de un paciente en tratamiento con anticoagulantes dicumarínicos que presente una hemorragia digestiva alta con signos de inestabilidad, hay que administrarle vitamina K, 10 mL/kg de plasma fresco congelado y 25-50 UI/kg de complejo protrombínico, todo ello por la vía endovenosa.
- b) En el caso de un paciente que toma rivaroxabán y presenta una hemorragia digestiva alta grave y está hemodinámicamente inestable, hay que administrarle 5 g de idarucizumab por la vía endovenosa.
- c) Si en el caso de un paciente con una hemorragia digestiva alta se detecta por medio de una endoscopia una úlcera Forrest IIa, hay que retomar la dieta oral inmediatamente.
- d) En el caso de un paciente con una hemorragia digestiva alta no varicosa, la dosis de omeprazol es de 40 mg de carga y una perfusión continua en dosis de 40 mg/h.

Caso 3

Mujer de 32 años, británica, que reside habitualmente en Manchester y que en los meses de verano trabaja en una empresa turística de Magaluf. No tiene antecedentes patológicos relevantes ni alergias medicamentosas conocidas. No sigue tratamientos médicos, excepto tomas puntuales de paracetamol en las crisis de migraña. Refiere consumo de alcohol, sobre todo los fines de semana. Pesa 62 kg.

Es trasladada de madrugada por una ambulancia al servicio hospitalario de urgencias tras haber ingerido una gran cantidad de ginebra y medicación. Los sanitarios aportan una caja de 20 comprimidos de 500 mg de paracetamol con todos los blísteres vacíos, pero no se sabe cuántos debe de haber tomado antes de la sobreingesta de ginebra. Tampoco se sabe con exactitud la hora de la ingesta, pero fue vista algo nerviosa a la hora de la cena (sobre las 21 h) tras haberse hecho una prueba de embarazo que dio resultado positivo.

Al llegar a urgencias estas son sus constantes vitales: tensión arterial (TA), 113/78 mmHg; frecuencia cardíaca (FC), 72 lpm; frecuencia respiratoria (FR), 12 rpm; saturación de oxígeno (SatO₂), 98 % en el aire ambiente; temperatura (T^a), 35,7 °C; glucemia capilar, 82 mg/dL.

Está somnolienta y da respuestas verbales incoherentes, con habla disártrica y poco entendible. Presenta fetor enólico. Se retira a los estímulos dolorosos, tiene náuseas continuas y restos de vómito en la ropa (según los sanitarios de la ambulancia, ha vomitado dos veces durante el trayecto, pero no han detectado restos de los comprimidos en el vómito).

Otras exploraciones: eupneica, con murmullo vesicular conservado en todos los campos, aparentemente sin distrés; corazón rítmico sin soplos. Abdomen anodino, blando, depresible, sin VCM. Pupilas medias reactivas, hiporreflexia global bilateral, no se detectan paresias (se retira a los estímulos dolorosos en todas las extremidades). Es imposible explorar la deambulación dado su estado.

1. Según esta situación clínica descrita, señale la afirmación más adecuada sobre el problema principal de salud de la paciente:

- a) Presenta un cuadro de vómitos asociados al primer trimestre del embarazo.
- b) Tiene síntomas de intoxicación alcohólica aguda y se han objetivado datos en su entorno que pueden sugerir, además, una sobredosis de paracetamol.
- c) La sobredosis medicamentosa sugiere una depresión mayor, por lo que debe ser valorada cuanto antes por un especialista en psiquiatría.
- d) Tiene síntomas claros que sugieren una intoxicación masiva por paracetamol.

2. ¿Qué medida terapéutica debe priorizarse?

- a) Derivarla la paciente al servicio de ginecología para una valoración inicial del embarazo.
- b) Solicitar una prueba de alcoholemia para saber el grado de intoxicación a fin de hacer una estimación del tiempo de observación que requerirá hasta que metabolice el alcohol.
- c) Tratar inicialmente las náuseas y los vómitos.
- d) Hacerle un lavado gástrico dada la posible sobredosis de paracetamol.

3. Si se decide hacer un estudio analítico, ¿cuál de los parámetros siguientes es el que es más necesario conocer?

- a) Paracetamol en la sangre (acetaminofeno).
- b) Alcoholemia en la sangre.
- c) Tóxicos en la orina.
- d) β -hCG en la sangre.

4. En el caso clínico descrito, señale la afirmación correcta sobre una potencial indicación de descontaminación digestiva:

- a) Dado que la paciente vomita, hay que hacerle un lavado gástrico y al final administrarle carbón activado.
- b) No debería ser una prioridad, dadas la situación clínica y la falta de información sobre el intervalo de tiempo desde la ingesta.
- c) Es suficiente administrarle carbón activado por la vía oral, pero antes administrar siempre un antiemético con el fin de evitar que vuelva a vomitar.
- d) Se puede plantear un lavado intestinal con una solución evacuante.

5. ¿En cuál de las intoxicaciones siguientes no está indicado el carbón activado como técnica de descontaminación porque no tiene capacidad de adsorción del tóxico?

- a) Intoxicación con etanol.
- b) Intoxicación con paracetamol.
- c) Intoxicación con aspirina.
- d) Intoxicación con anfetaminas.



6. **En este caso clínico, si se valorase la necesidad de administrar antídotos a la paciente, ¿cuál sería el adecuado?**
- a) Tiamina.
 - b) Piridoxina.
 - c) Flumazenilo.
 - d) N-acetilcisteína.
7. **¿Con qué toxíndrome se puede correlacionar mejor la situación clínica de esta paciente?**
- a) Opioide.
 - b) Sedativo.
 - c) Anticolinérgico.
 - d) Serotoninérgico.
8. **¿Cuál es el intervalo o margen de tiempo óptimo para hacer una determinación analítica cuantitativa de paracetamol (o de su metabolito acetaminofeno) tras sospechar una sobredosis puntual de este fármaco, para que sea útil para decidir el potencial riesgo de hepatotoxicidad y el tratamiento adecuado?**
- a) A partir de las dos horas desde la toma.
 - b) Se puede detectar en cualquier momento tras la toma.
 - c) A partir de la cuarta hora desde la toma.
 - d) A partir de los treinta minutos desde la toma.
9. **Los resultados de la analítica son los siguientes: hemoglobina, 13 g/dL; hematocrito, 38,4 %; VCM, 92 fl; TP, 100 %; glucosa, 83 mg/dL; creatinina, 1,0 mg/dL; sodio, 138 mEq/L; láctico, 0,9; acetaminofeno, 44 µg/mL; etanol, 1,89 g/dl; GSV pH, 7,36; CO₃H, 27,2 mEq/L.**
- Señale la afirmación correcta:**
- a) Los niveles de acetaminofeno descartan claramente el riesgo de hepatotoxicidad, por lo que no debe administrarse ningún antídoto.
 - b) Hay que administrar un antídoto (N-acetilcisteína) en perfusión y volver a valorar el caso posteriormente, dado que no se sabe la hora exacta de la toma.
 - c) Hay que administrar un antídoto (tiamina) dado el riesgo de síndrome de Wernicke-Korsakov.
 - d) Hay que esperar unas tres horas para que la paciente haya metabolizado un poco el alcohol y posteriormente derivarla al servicio de psiquiatría.

- 10. La sobredosis o intoxicación por paracetamol puede ocasionar un fracaso hepático, pero ¿puede generar nefrotoxicidad?**
 - a) No, excepto en la fase de fracaso multiorgánico final de la propia insuficiencia hepática aguda.
 - b) En menos del 10 % de los casos, por un mecanismo de toxicidad directa sobre el túbulo proximal.
 - c) El paracetamol no es nefrotóxico, pero cuando se trata con antidotos estos sí podrían provocar nefrotoxicidad.
 - d) Solo se produce en personas con hipertensión o diabetes.

- 11. En el caso de un paciente intoxicado por monóxido de carbono, señale la respuesta incorrecta respecto a la indicación clara de tratamiento con oxígeno hiperbárico:**
 - a) Debe indicarse si se trata de un lactante inconsciente con un valor de carboxihemoglobina del 14 %.
 - b) Debe indicarse si se trata de una gestante con cefalea y náuseas y un valor de carboxihemoglobina del 18 %.
 - c) Debe indicarse si se trata de un paciente asintomático con un valor de carboxihemoglobina del 10 % y patología neurológica previa.
 - d) Debe indicarse si se trata de un paciente con un valor de carboxihemoglobina del 10 % y que haya sido rescatado inconsciente del lugar de exposición al monóxido de carbono.

- 12. ¿Cuál es el intervalo de tiempo óptimo para llevar a cabo de manera eficaz una descontaminación digestiva con carbón activado para tratar una intoxicación medicamentosa aguda por la vía oral?**
 - a) Menos de 12 horas.
 - b) 6 horas.
 - c) 4 horas.
 - d) 2 horas.

- 13. Señale la respuesta correcta sobre los criterios de indicación de trasplante hepático tras una sobredosis de paracetamol:**
 - a) Presencia de signos de encefalopatía de grado III.
 - b) Cociente GOT/GPT inferior a 1.000 UI/L.
 - c) Descenso del TP en un 20 % del valor basal.
 - d) GOT superior a 1.000 UI/L.

14. **¿En cuál de las situaciones siguientes es prudente y recomendable indicar una descontaminación con carbón activado por la vía oral tras una intoxicación?**
 - a) Paciente que recientemente ha tomado fármacos y que está en coma o cuyo nivel de la conciencia ha disminuido (responde solamente al dolor).
 - b) Embarazada en el primer trimestre de la gestación que ha tomado unos 15 g de paracetamol hace menos de una hora.
 - c) Paciente que ha tomado recientemente (hace menos de una hora) unos 15 g de paracetamol pero que no colabora y se niega rotundamente a tomar el carbón activado.
 - d) Paciente consciente que ha tomado 200 mg de diazepam hace unas seis horas.

15. **¿Cuál de los siguientes grupos farmacológicos está presente en la mayoría de las intoxicaciones farmacológicas en nuestro entorno?**
 - a) Benzodiacepinas.
 - b) Paracetamol.
 - c) Digoxina.
 - d) Ibuprofeno.

16. **Señale la afirmación correcta sobre la determinación de drogas de abuso en la orina:**
 - a) Ayuda a pronosticar la gravedad de la intoxicación.
 - b) Confirma el diagnóstico de la intoxicación independientemente de la clínica.
 - c) Es necesaria para determinar un diagnóstico racional de la intoxicación.
 - d) No debe utilizarse como guía para tomar decisiones terapéuticas o clínicas.

17. **¿Cuál de las respuestas siguientes no es uno de los criterios diagnósticos de un síndrome de hiperemesis cannabinoide?**
 - a) Consumo crónico de cannabis (más de un año).
 - b) Mejoría con la abstinencia de cannabis.
 - c) Alivio de los síntomas con duchas de agua fría.
 - d) Los resultados de las pruebas complementarias para valorar el aparato digestivo son normales.

- 18. ¿En cuál de las situaciones clínicas siguientes está totalmente contraindicado administrar flumazenil?**
- a) Disminución del nivel de la conciencia (3 en la escala de coma de Glasgow o sin respuesta al dolor) de origen incierto.
 - b) Disminución del nivel de la conciencia (8 en la escala de coma de Glasgow o respuesta al dolor pero no a las órdenes verbales) y convulsiones unas horas antes.
 - c) Disminución del nivel de la conciencia (12 en la escala de coma de Glasgow o respuesta a las órdenes verbales) e insuficiencia respiratoria.
 - d) Disminución del nivel de la conciencia (10 en la escala de coma de Glasgow o respuesta al dolor pero no a las órdenes verbales) e hipotensión.
- 19. ¿Cuál de los criterios siguientes es prescindible para sospechar o diagnosticar un toxíndrome?**
- a) El nivel de la conciencia y el grado de respuesta al dolor.
 - b) El tamaño de las pupilas.
 - c) Los reflejos osteotendinosos.
 - d) El valor en la escala de coma de Glasgow.
- 20. En un caso de sobredosis de opiáceos, ¿cuál es el objetivo terapéutico principal para decidir administrar un antídoto (naloxona)?**
- a) Revertir la disminución del nivel de la conciencia cuanto antes.
 - b) Corregir la miosis puntiforme.
 - c) Revertir la insuficiencia respiratoria asociada.
 - d) Evitar un posible síndrome de abstinencia.

Preguntas de reserva

- 21. ¿En cuál de las intoxicaciones siguientes es preceptivo hacer una electrocardiografía a causa de la potencial cardiotoxicidad?**
- a) Intoxicación por cannabis.
 - b) Intoxicación por benzodiacepinas.
 - c) Intoxicación por monóxido de carbono.
 - d) Intoxicación por metformina.



- 22. Señale la afirmación correcta sobre la utilización de N-acetilcisteína como antídoto:**
- a) Solamente puede administrarse por la vía endovenosa.
 - b) En caso de sospecha de toma de una dosis muy alta, puede iniciarse la administración de N-acetilcisteína antes de disponer la paracetamolemia del paciente.
 - c) Produce habitualmente reacciones adversas graves al administrarla por la vía endovenosa, que obligan siempre a interrumpir la administración.
 - d) Hay que interrumpir la administración si disminuye el tiempo de protrombina.
- 23. Es habitual que se produzca una acidosis metabólica grave en la fase inicial de la intoxicación por determinados productos. Señale la respuesta incorrecta:**
- a) Etilenglicol.
 - b) Digoxina.
 - c) Metanol.
 - d) Metformina.
- 24. ¿Cuál de los signos siguientes no se espera detectar en un caso de intoxicación con un toxíndrome serotoninérgico?**
- a) Temblor.
 - b) Sudoración profusa.
 - c) Hipertermia.
 - d) Sequedad de la piel.

Caso 4

Hombre de 62 años sin alergias medicamentosas conocidas. Exfumador desde 2008 (DTA: 20 paquetes/año) sin factores de riesgo cardiovascular conocidos, ni broncopatía conocida previa, ni antecedentes de tuberculosis pulmonar.

Hace unos años empezó a padecer disnea, que le obligó a múltiples visitas al servicio de urgencias a finales de 2019 y a principios de 2020. Está en estudio por el servicio de cardiología desde diciembre de 2021 por dicha disnea, sin evidencia de cardiopatía estructural en los resultados de una ecografía y una ergometría clínica y eléctricamente negativa pero suspendida antes de alcanzar la frecuencia cardíaca máxima por disnea y desaturación.

- Antecedentes quirúrgicos: hernioplastia de Lichtenstein izquierda.
- Tratamiento habitual: fluticasona/vilanterol, con mal cumplimiento terapéutico.
- Situación basal: natural de Marruecos, vivió unos años en los Países Bajos y reside en Mallorca desde 2008. No tiene familiares en la isla y vive en un piso compartido. Trabajó como comerciante, posteriormente en la recolección de tomates y actualmente trabaja en la construcción, en la que está expuesto a una gran inhalación de polvo.
- Enfermedad actual: el paciente acude al servicio de urgencias por disnea progresiva, que en la última semana se ha convertido en disnea por esfuerzos pequeños, a la cual se asocia sensación distérmica y tos con expectoración amarillenta. No ha presentado dolor torácico, palpitaciones ni edemas en las extremidades inferiores.
- Exploración física: temperatura (T^a), 36,3 °C; frecuencia cardíaca (FC), 75 lpm; tensión arterial (TA), 130/72 mmHg; frecuencia respiratoria (FR), 24 rpm; saturación de oxígeno ($SatO_2$), 92 % en el aire ambiente.
- Aparato circulatorio: tonos cardíacos rítmicos, sin soplos ni roces. No presenta edemas maleolares ni signos de trombosis venosa profunda.
- Auscultación respiratoria: eupneico en reposo, crepitantes secos diseminados.

1. ¿Cuál de los diagnósticos siguientes es más ajustado en este caso clínico?

- a) Insuficiencia cardíaca congestiva.
- b) Síndrome de agudización de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
- c) Posible síndrome de agudización de la EPOC.
- d) Tromboembolia pulmonar.

2. **¿Cuál de las respuestas siguientes no es uno de los criterios de ingreso hospitalario en un caso de crisis asmática?**
 - a) El paciente requiere oxigenoterapia para mantener la saturación de oxígeno por encima del 95 %.
 - b) El paciente está sintomático después del tratamiento.
 - c) El paciente presenta un PEF o FEV1 inferior al 50-60 % tras el tratamiento.
 - d) Ha fracasado el tratamiento ambulatorio con glucocorticoides por la vía oral.

3. **¿Qué criterio se determina en la Guía Española de la EPOC (GesEPOC) de 2021 para clasificar el riesgo de los pacientes?**
 - a) FEV1 prebroncodilatación, escala mMRC y número de agudizaciones al año.
 - b) FEV1 postbroncodilatación, escala mMRC e índice BODE/BODEX.
 - c) FEV1 postbroncodilatación, escala mMRC y escala GOLD.
 - d) FEV1 postbroncodilatación, escala mMRC y número de agudizaciones al año.

4. **¿Cómo debe clasificarse este episodio del caso clínico descrito, con relación a su gravedad?**
 - a) Leve.
 - b) Moderado.
 - c) No se puede clasificar.
 - d) Grave, si el valor en la mMRC basal es 2.

5. **Ante esta situación ¿qué pruebas complementarias deben solicitarse en un primer momento?**
 - a) Hemograma, bioquímica, hemocultivos, gasometría venosa, electrocardiograma y radiografía del tórax.
 - b) Hemograma, bioquímica de marcadores cardíacos, coagulación con dímero-D, gasometría arterial, antígeno del SARS-CoV-2, PCR para detectar el virus de la gripe, electrocardiograma y radiografía del tórax.
 - c) Hemograma, bioquímica con marcadores miocárdicos, coagulación con dímero-D, gasometría venosa y ácido láctico.
 - d) Hemograma, bioquímica con marcadores miocárdicos, gasometría arterial, electrocardiograma, radiografía del tórax y test de tuberculina.

Estos son los resultados de la analítica:

- Leucocitos: 15.200 células/mL (neutrófilos: 74,5 %; linfocitos: 11,9 %; eosinófilos: 0,1 %).
- Hemoglobina: 11,5 g/dL normo normo.
- Plaquetopenia: 106.000 plaquetas/mm³.
- Coagulación: TP, 71 %, INR 1,24; dímero-D, 263.
- Bioquímica: glucemia, 151 mg/dL; creatinina, 0,7 mg/dL; sodio, 138 mEq/L; potasio, 4,7 mEq/L.
- GOT, 107 UI/L; GPT, 96 UI/L; GGT, 81 UI/L; FA, 185 UI/L; CK, 58 UI/L; troponina < 10 UI/mL; PCR, 20,20 mg/dL; PCT, 0,16.
- Gasometría arterial AA: pH, 7,42; pO₂, 50 mmHg; pCO₂, 51 mmHg; HCO₃, 33,1 mEq/L.

6. Dados los resultados anteriores y en el supuesto de que el resultado de la PCR para detectar el virus de la gripe fuese positivo para la gripe A, ¿cuál de las siguientes actuaciones terapéuticas sería correcta?

- a) Nebulizaciones con salbutamol y 75 mg de oseltamivir cada 12 horas.
- b) Inhalaciones con salbutamol con cámara espaciadora y 75 mg de oseltamivir cada 12 horas.
- c) Nebulizaciones con salbutamol, 75 mg de oseltamivir cada 12 horas y corticoides por la vía endovenosa.
- d) Inhalaciones con salbutamol con cámara espaciadora, 75 mg de oseltamivir cada 12 horas y corticoides por la vía endovenosa.

7. ¿A qué se refiere el índice de Horowitz?

- a) Al gradiente alveoloarterial de oxígeno.
- b) A la PaO₂ ideal.
- c) Al gradiente de oxígeno en el glomérulo.
- d) Al cociente PaO₂/FiO₂.

8. De los criterios de gravedad del síndrome de agudización de la EPOC, señale el incorrecto en un caso de agudización grave:

- a) Disnea 3 o 4 de la escala mMRC.
- b) SatO₂ < 90 % o PaO₂ < 60 mmHg.
- c) Acidosis respiratoria grave (pH < 7,30).
- d) Edemas periféricos de nueva aparición.



9. **¿Qué revelan los resultados de la gasometría arterial?**
- a) Acidosis respiratoria aguda e hipoxemia.
 - b) Acidosis respiratoria crónica e hipoxemia.
 - c) Alcalosis metabólica e hipoxemia.
 - d) Alcalosis respiratoria compensada e hipoxemia.
10. **Señale la afirmación falsa sobre el síndrome de distrés respiratorio del adulto:**
- a) Se trata de una lesión inflamatoria de los pulmones debida al aumento de la permeabilidad de la membrana capilar pulmonar, la disminución de la distensibilidad pulmonar y la pérdida del tejido pulmonar ventilado.
 - b) Presenta infiltrados bilaterales difusos, no explicados por derrame, atelectasia lobar o pulmonar o nódulos pulmonares.
 - c) Se considera leve cuando el cociente $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ es 200-300.
 - d) En la mayoría de los casos no es necesaria la ventilación mecánica, que se aplica con presión teleespiratoria positiva (PEEP) para evitar el colapso de los alvéolos.
11. **¿Cuál de los rasgos siguientes se considera que no es tratable en los casos de síndrome de agudización de la EPOC?**
- a) Eosinofilia inferior a 250 células/mm³.
 - b) Neumonía.
 - c) Isquemia miocárdica.
 - d) Problemática social.
12. **¿Cuál de las intervenciones siguientes se considera esencial en el abordaje del síndrome de agudización de la EPOC?**
- a) Mantener la saturación de oxígeno por encima del 90 %.
 - b) Iniciar un tratamiento antibiótico de manera precoz.
 - c) Administrar un tratamiento con corticoides sistémicos.
 - d) Optimizar la broncodilatación.

- 13. Entre las pruebas básicas hospitalarias, la GesEPOC considera la radiografía del tórax, el electrocardiograma, la gasometría arterial y la analítica (hemograma y bioquímica estándar). ¿Cuál de los biomarcadores básicos siguientes hay que incluir para el síndrome de agudización de la EPOC?**
- a) Proteína C reactiva.
 - b) Pro-BNP.
 - c) Procalcitonina.
 - d) Dímero-D.
- 14. La escala PESI (*pulmonary embolism severity index*) considera que ciertas comorbilidades aumentan la gravedad del tromboembolismo pulmonar. Señale la respuesta incorrecta:**
- a) Cáncer.
 - b) Diabetes *mellitus*.
 - c) Insuficiencia cardíaca.
 - d) EPOC.
- 15. ¿Con cuál de los siguientes parámetros gasométricos se recomienda iniciar un tratamiento de ventilación mecánica no invasiva?**
- a) $\text{PaO}_2 > 60 \text{ mmHg}$.
 - b) $\text{pH} < 7,35$.
 - c) $\text{pCO}_2 < 45 \text{ mmHg}$.
 - d) $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$.

Se recibe el siguiente informe de la radiografía del tórax: silueta cardíaca de tamaño normal; patrón intersticial difuso en ambos campos pulmonares, que debe correlacionarse según la clínica y los antecedentes; se observa un tenue aumento de la densidad pulmonar en el nivel de los lóbulos medio e inferior derechos; no hay derrame pleural ni pericárdico.

- 16. Señale la afirmación correcta dado este contexto clínico y con una PCR de 20,2:**
- a) Está indicado iniciar un tratamiento con antibióticos.
 - b) Informa de un parámetro de inflamación que requiere un tratamiento con corticoides.
 - c) Es un parámetro que indica una agudización muy grave.
 - d) No es necesaria la profilaxis antitrombótica.

- 17. ¿Cuál de los diagnósticos siguientes es el más probable?**
- a) Neumonía viral por el SARS-CoV-2 (COVID-19).
 - b) Síndrome de agudización de la EPOC con neumonía.
 - c) Insuficiencia cardíaca aguda.
 - d) Enfermedad tromboembólica pulmonar.
- 18. Señale la afirmación falsa respecto a los parámetros iniciales de la ventilación mecánica no invasiva en modo BiPAP:**
- a) Los valores ideales de IPAP se sitúan entre 15 y 20 cm de H₂O.
 - b) Los valores iniciales de IPAP se sitúan entre 8 y 12 cm de H₂O.
 - c) Se aumenta la IPAP hasta conseguir disminuir la frecuencia respiratoria (< 25 rpm) y un volumen tidal entre 3 y 5 mL/kg de peso ideal.
 - d) Los niveles habituales de EPAP oscilan entre 4 y 8 cm de H₂O.
- 19. ¿En qué caso no está indicada la profilaxis tromboembólica en el síndrome de agudización de la EPOC?**
- a) En las agudizaciones graves.
 - b) En las agudizaciones muy graves.
 - c) En las agudizaciones moderadas con un paciente activo.
 - d) En las agudizaciones moderadas con un paciente inactivo.
- 20. Señale la afirmación falsa sobre la ventilación mecánica no invasiva:**
- a) Debe aplicarse sin demora a los pacientes con edema agudo de pulmón cardiogénico o insuficiencia cardíaca hipertensiva que presenten trabajo respiratorio importante (FR > 25 rpm y/o SpO₂ < 90 %).
 - b) Está indicada en los casos de edema agudo de pulmón en modo CPAP.
 - c) Está indicada en los casos de edema agudo de pulmón en pacientes de EPOC en modo BiPAP.
 - d) Consigue mejorar la función ventricular izquierda al aumentar la postcarga.

Preguntas de reserva

21. Señale la afirmación correcta sobre los parámetros compensatorios del equilibrio ácido-base:

- a) En la alcalosis respiratoria, por cada descenso de 10 mmHg de la $p\text{CO}_2$ la concentración de HCO_3^- disminuye 6 mEq/L si el trastorno es agudo.
- b) En la alcalosis respiratoria, por cada descenso de 10 mmHg de la $p\text{CO}_2$ la concentración de HCO_3^- disminuye 2 mEq/L si el trastorno es crónico.
- c) En la acidosis respiratoria, por cada aumento de 10 mmHg de la $p\text{CO}_2$ la concentración de HCO_3^- aumenta 5 mEq/L si el trastorno es agudo.
- d) En la acidosis respiratoria, por cada aumento de 10 mmHg de la $p\text{CO}_2$ la concentración de HCO_3^- aumenta 3,5 mEq/L si el trastorno es crónico.

22. Señale la afirmación correcta:

- a) Polipnea: inspiración profunda y prolongada.
- b) Hiperpnea: disnea que se produce en la posición de decúbito supino.
- c) Platipnea: disnea que se produce en la posición de decúbito lateral.
- d) Trepopnea: disnea que se produce en la posición erecta o vertical y que se alivia en la posición de decúbito.

23. ¿Cuál de los parámetros siguientes no se incluye en el índice DECAF que se recomienda utilizar para valorar el riesgo de mortalidad en el síndrome de agudización de la EPOC?

- a) Disnea.
- b) Leucocitosis.
- c) Consolidación.
- d) Fibrilación auricular.

24. ¿Cuál es el parámetro clínico que da más valor a la puntuación de la escala PESI?

- a) Frecuencia respiratoria.
- b) Edad.
- c) Cáncer.
- d) Alteración del estado mental.

Caso 5

Hombre de 43 años, de 80 kg de peso y complexión atlética, víctima de un accidente de circulación: el vehículo en el que ocupaba el asiento del copiloto se ha salido de la carretera a 110 km/h y ha chocado con la parte frontolateral derecha contra una pared. La víctima llevaba puesto el cinturón de seguridad. Ha sido necesaria la intervención de los bomberos durante veinte minutos para excarcelarla. Sus acompañantes han fallecido.

Una ambulancia de soporte vital avanzado (SVA) ha llegado al lugar del accidente a la media hora, pero los sanitarios han encontrado a la víctima ya inmovilizada por los bomberos, fuera del vehículo. Respondía de forma confusa, obedecía a las órdenes verbales abriendo los ojos, estaba taquicárdico y presentaba signos de hipoperfusión distal.

Tras estabilizar al paciente, ha sido trasladado a un centro hospitalario; en el triaje lo han clasificado como prioridad de nivel I, de modo que ha ingresado en un box de urgencias, donde se ha hecho cargo el equipo de intervención protocolizado del hospital. En la transferencia del caso, los sanitarios de la ambulancia han informado de que han canalizado dos vías periféricas al paciente y le han administrado 1.500 mL de cristaloides y media ampolla de fentanilo (75 µg de una ampolla de 150 µg). El paciente llevaba un collarín cervical, oxigenación en VMK con FiO₂ de 0,5, colchón de vacío y una férula en la pierna derecha.

1. Señale la respuesta correcta sobre la primera actuación que deben llevar a cabo los sanitarios de la ambulancia de SVA en este caso:
 - a) Canalizar dos vías al paciente y transfundirle cristaloides en bolo a razón de 500 mL en 30 minutos, dado que presenta signos evidentes de *shock*.
 - b) Iniciar la valoración primaria para descartar posibles lesiones potencialmente mortales para el paciente.
 - c) Ordenar al equipo de rescate que asegure la zona antes de iniciar la asistencia y utilizar los medios de protección individual establecidos.
 - d) Ordenar la organización inmediata del traslado de la víctima dado su evidente estado de gravedad.

2. **¿Cuál de las respuestas siguientes no es un factor de riesgo para la identificación de un paciente con lesiones potencialmente graves y la decisión de trasladarlo al centro más adecuado?**
 - a) Gran deformidad del habitáculo con necesidad de excarcelación durante más de veinte minutos.
 - b) Caída de un adulto desde seis metros de altura.
 - c) Evidencia de única fractura de un hueso largo.
 - d) Coexistencia de fallecidos en el mismo compartimento de la víctima.

3. **Señale la respuesta falsa sobre la enfermedad traumática:**
 - a) Actualmente es considerada una verdadera epidemia del siglo XXI dado el importante impacto que genera en los países desarrollados.
 - b) En los países desarrollados, la mortalidad es significativamente superior en la franja de edad de adultos jóvenes (16-44 años).
 - c) El concepto de *distribución trimodal de la muerte* en la enfermedad traumática hace referencia a los tres periodos en que se produce la muerte de una persona que ha sufrido un accidente. El primer periodo, conocido como «hora de oro», es aquel en el que se centran todos los esfuerzos de los programas de atención en politraumatismo grave.
 - d) La estrategia en que se basan los programas de atención a pacientes politraumatizados graves es tratar primero la lesión que amenaza más la vida de la persona accidentada.

4. **Señale la afirmación más adecuada en relación con el caso clínico descrito:**
 - a) Se trata de un caso de riesgo bajo, independientemente del nivel de urgencia asignado en el triaje hospitalario, y no requiere una actuación protocolizada de traumatismo grave.
 - b) Se trata de un paciente con lesiones potencialmente graves que requieren una actuación protocolizada y sistematizada identificando y abordando las más graves.
 - c) El paciente es un politraumatizado grave y está en *shock*, por lo que hay que avisar al quirófano para trasladarlo inmediatamente desde el mismo servicio de urgencias y hacerle una laparotomía exploradora.
 - d) Claramente el paciente presenta lesiones graves, de modo que la primera actuación debe ser hacerle una tomografía computarizada (TC) completa para conocer el alcance de las lesiones.

5. **Señale la afirmación falsa sobre el protocolo de SVA para los casos de traumatismo grave:**
- a) Es un conjunto ordenado de tareas multidisciplinares que permite identificar a los pacientes potencialmente graves, evaluar el patrón lesional y determinar qué pruebas complementarias son necesarias para completar la evaluación, todo ello encaminado a la evaluación priorizada de las lesiones del paciente.
 - b) Es prioritario identificar las lesiones graves durante la primera fase de la valoración (valoración primaria) y las menos graves en la secundaria, y deben iniciarse la reanimación y el tratamiento una vez finalizadas ambas fases.
 - c) La valoración secundaria permite componer el patrón de lesiones asociadas al traumatismo con el objetivo de determinar las pruebas complementarias.
 - d) Saber qué pruebas son necesarias y relevantes dependiendo de la exploración y la situación del paciente es una competencia imprescindible para todo clínico que atienda a estos pacientes.
6. **El nivel de conciencia de los pacientes politraumatizados se determina por medio de la escala de coma de Glasgow (CGS). Señale la respuesta correcta en relación con el caso clínico descrito:**
- a) La puntuación en la CGS es de 9 (O = 3, V = 5, M = 1).
 - b) La puntuación en la CGS es de 13 (O = 3, V = 6, M = 4).
 - c) La puntuación en la CGS es de 15 (O = 4, V = 5, M = 6).
 - d) La puntuación en la CGS es de 13 (O = 3, V = 4, M = 6).
7. **Señale la afirmación falsa en relación con el control adecuado de la vía aérea en un caso de traumatismo grave:**
- a) La causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea es el nivel de conciencia bajo.
 - b) El objetivo principal es permitir la ventilación y la oxigenación adecuadas. Si la víctima de un accidente está orientada y habla correctamente, eso indica que la vía aérea es permeable y que tiene una buena perfusión cerebral.
 - c) El mal control de la vía aérea hace más difícil cualquier maniobra efectiva de reanimación posterior y aumenta la probabilidad de lesiones neurológicas irreversibles.
 - d) Forma parte de las acciones que deben llevarse a cabo en la valoración secundaria.

8. Señale la afirmación correcta en relación con el *shock* en los pacientes politraumatizados:
- a) En el *shock* de grado I se estiman pérdidas entre el 30 % y el 40 % del volumen de sangre, de modo que se requiere transfusión de hemoderivados.
 - b) El primer paso en el abordaje y el tratamiento del *shock* es reconocerlo: los signos más sensibles son la taquicardia y las características del pulso distal.
 - c) La caída de la tensión arterial se produce en el *shock* de grado II, en que la pérdida de sangre es superior al 40 %, lo cual requiere perfusión de concentrado de hematíes, plasma y plaquetas en proporción 1:2:2.
 - d) La prioridad en los casos de politraumatismo con *shock* hemorrágico es hacer una prueba de imagen que identifique la zona sangrante y la necesidad de intervenir quirúrgicamente.
9. ¿Cuál de las respuestas siguientes no es una de las lesiones que deterioran de forma significativa la ventilación a corto plazo y que deben identificarse en la valoración primaria?
- a) Hemotórax masivo.
 - b) Neumotórax a tensión.
 - c) Fracturas costales múltiples.
 - d) Neumotórax abierto.
10. ¿Cuál de los siguientes signos ecográficos realizados en el box de reanimación de un paciente politraumatizado en decúbito supino descarta con una especificidad cercana al 100 % un neumotórax traumático del área explorada?
- a) Presencia de deslizamiento pleural.
 - b) Existencia de líneas A anterior.
 - c) Presencia de líneas B anterior.
 - d) Visualización del pulso del pulmón.
11. ¿Cuál de las escalas siguientes utilizadas en la enfermedad traumática predice con más exactitud el pronóstico de mortalidad?
- a) Trauma Score Revisado (TRS).
 - b) Trauma Score (TS).
 - c) Injury Severity Score (ISS)
 - d) Abbreviated Injury Scale (AIS).



12. **¿Cuál es el mecanismo lesional más frecuente en la fractura cervical C1, conocida como «fractura de Jefferson»?**
- a) Hiperextensión cervical.
 - b) Compresión axial.
 - c) Rotación y flexión lateral.
 - d) Distracción cervical.
13. **¿Cuál es la sospecha más probable en el caso de un paciente politraumatizado con tensión arterial de 86/50 mmHg, frecuencia cardíaca de 45 lpm y piel caliente?**
- a) *Shock* hemorrágico de grado III.
 - b) *Shock* obstructivo causado por un taponamiento cardíaco.
 - c) *Shock* medular causado por una lesión por encima de la vértebra T5.
 - d) El traumatismo torácico de alta energía le ha provocado una lesión cardíaca que ha causado un *shock* cardiogénico.
14. **¿Con qué signos típicos se sospecha una hipertensión intracraneal?**
- a) Nivel bajo de conciencia, bradicardia e hipertensión arterial.
 - b) Nivel bajo de conciencia, taquicardia e hipertensión arterial.
 - c) Amnesia retrógrada, bradicardia e hipotensión arterial.
 - d) Hipertensión arterial, amnesia y taquicardia.
15. **Señale la afirmación correcta sobre las hemorragias intracraneales en un traumatismo craneoencefálico de alta energía:**
- a) El hematoma epidural rara vez se asocia a fracturas craneales.
 - b) El hematoma subdural se produce por el desgarró y la rotura de vasos sanguíneos.
 - c) El hematoma intraventricular se asocia a un buen pronóstico.
 - d) La hemorragia subaracnoidea se produce por la rotura de un aneurisma.

16. Señale la afirmación falsa sobre el traumatismo abdominal grave:

- a) Las lesiones desapercibidas abdominales y del anillo pélvico son causa de muerte prevenible después de un traumatismo torácico.
- b) Las lesiones de las estructuras viscerales retroperitoneales son fáciles de reconocer por medio del protocolo FAST y clínicamente por la manifestación temprana de irritación peritoneal.
- c) La lesión diafragmática es poco frecuente, y cuando ocurre suele darse en el hemidiafragma posterolateral izquierdo.
- d) En los casos de lesiones de órganos sólidos intraabdominales en un politraumatismo hemodinámicamente estable está indicada una actitud conservadora.

17. ¿Cuál de las posibles fracturas del anillo pélvico cursa más a menudo con lesión del complejo ligamentoso posterior y está asociada a un *shock* de grado III-IV si no se hace un abordaje adecuado?

- a) Fractura desplazada del ala ilíaca derecha (tipo A en la clasificación de Tile).
- b) Fractura en libro abierto con diástasis pubiana de menos de 2,5 cm (tipo B1 en la clasificación de Tile).
- c) Fractura en mariposa o bilateral de ramas ileopubianas e isquiopubianas.
- d) Fractura con desplazamiento vertical de la articulación sacroilíaca y diástasis del pubis de más 2,5 cm (tipo C en la clasificación de Tile).

18. La incapacidad para la extensión dorsal de la mano y los dedos en ligera flexión del miembro superior en el contexto de una fractura supracondílea de húmero hace sospechar una lesión de un nervio. ¿Cuál?

- a) Nervio cubital.
- b) Nervio radial.
- c) Nervio mediano.
- d) Nervio circunflejo.



- 19. Durante la valoración secundaria del caso clínico descrito, una vez estabilizado el paciente se le retira la férula de vacío y se observa una gran deformidad del tercio medio del muslo derecho con una herida contusa de 11 cm, sangrante y con exposición de hueso. Señale la acción correcta:**
- a) Hay que cohibir la hemorragia presionando con gasas estériles, comprobar el pulso distal e inmovilizar la fractura con una férula de yeso posterior.
 - b) Hay que administrar analgesia, cohibir la hemorragia y volver a colocar la férula de vacío.
 - c) Hay que cohibir la hemorragia, administrar analgesia, alinear la fractura e inmovilizarla con una tracción esquelética, y seguidamente comprobar el pulso distal y hacer una exploración neurológica de la extremidad.
 - d) La administración inicial de fentanilo a cargo del equipo de atención extrahospitalaria es suficiente; hay que suturar la herida e inmovilizar la fractura con una bota de yeso.
- 20. En relación con la pregunta anterior, ¿cuál es el tratamiento antibiótico de elección indicado?**
- a) 2 g de amoxicilina – ácido clavulánico por la vía endovenosa.
 - b) 2 g de cefazolina y 900 mg clindamicina, ambas por la vía endovenosa.
 - c) No se requiere tratamiento antibiótico.
 - d) 2 g de cefazolina y 5 mg/kg de peso de gentamicina.

Preguntas de reserva

- 21. Señale la afirmación correcta respecto a la evaluación de la resucitación con líquidos en un paciente con un traumatismo:**
- a) El exceso de bases es un mal indicador de la resucitación.
 - b) El bicarbonato sódico debe administrarse con un pH superior a 7,2.
 - c) La diuresis es un buen indicador de la reposición adecuada de volumen.
 - d) La normalización de la presión arterial y el pulso son los indicadores más fiables de que la perfusión del órgano y de los sistemas es adecuada.

- 22. ¿Cuál de los signos siguientes puede corresponder, con una probabilidad alta, a una lesión grave en un traumatismo craneoencefálico?**
- a) Rinorragia controlada con presión bidigital.
 - b) Herida en *scalp* del cuero cabelludo.
 - c) Anisocoria arreactiva.
 - d) Equimosis palpebral unilateral.
- 23. ¿Cuál de los parámetros siguientes no influye en la valoración de las quemaduras?**
- a) Extensión de la quemadura.
 - b) Peso del paciente.
 - c) Edad del paciente.
 - d) Presencia de lesiones asociadas.
- 24. Señale la afirmación falsa sobre los traumatismos en las gestantes:**
- a) El abordaje no difiere del que se aplica a la población general.
 - b) La causa principal de mortalidad fetal tras un traumatismo es la infección.
 - c) La gestación no incrementa la morbilidad de las embarazadas.
 - d) La gravedad de la lesión de la embarazada no se correlaciona con el estado del feto.

Caso 6

Un hombre de 79 años es trasladado al servicio de urgencias a las 7 de la tarde desde la residencia donde está internado; dado que no se dispone del informe de derivación, se desconocen sus antecedentes.

Está desorientado en el tiempo y el espacio, tiene problemas para recordar información sencilla, su discurso es incoherente y presenta inquietud psicomotriz. En ocasiones se pone muy nervioso y agitado porque tiene alucinaciones visuales (ve personas amenazantes), incluso cuando está solo; en otras ocasiones está somnoliento y desatento.

El servicio de urgencias se pone en contacto con la residencia, que informa de que el paciente ha presentado un episodio de agitación psicomotriz autolimitada, sin traumatismo craneoencefálico.

Así mismo, informa de sus antecedentes y del tratamiento:

- Sin alergias medicamentosas conocidas. No tiene deterioro cognitivo y es independiente para las actividades básicas de la vida diaria.
- Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, diabetes *mellitus* de tipo 2 e hipercolesterolemia (de más de diez años de evolución).
- Artrodesis lumbar (L3-L4-L5).
- Último ingreso hospitalario hace cinco meses: caída con traumatismo craneoencefálico y rabdomiólisis. Enfermedad cerebral de vasos pequeños. Neumonía basal izquierda. Infección urinaria por *Enterococcus faecium*. Síndrome confusional agudo.
- Tratamiento: 5 mg de enalapril cada 24 horas, 850 mg de metformina cada 24 horas, 20 mg de omeprazol cada 24 horas y 1 g de paracetamol si lo necesita.

EXPLORACIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

Exploración física: vigil, desorientado en el tiempo y el espacio, obedece órdenes sencillas. Fuerza muscular de 5/5 en las extremidades, sensibilidad conservada en todas las extremidades. Normorreflexia en el reflejo osteotendinoso. Marcha no explorada. Resto de la exploración física: no patológica.

Constantes vitales: tensión arterial, 140/75 mmHg; frecuencia cardiaca, 105 lpm; frecuencia respiratoria, 22 rpm; temperatura, 37,6 °C; saturación de oxígeno AA, 96 %.

Analítica: leucocitos, 14.000 células/ μ L; hemoglobina, 11,6 g/dL; hematocrito, 36,1 %; neutrófilos, 82,4 %; proteína C reactiva, 12,1 mg/dL; glucosa, 142 mg/dL; urea, 8 mg/dL; creatinina, 1 mg/dL. Examen manual del sedimento urinario: 500 leucocitos/ μ L.

1. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Debut típico de una demencia en un paciente anciano con una infección grave.
- b) Cuadro de delirium en un paciente anciano con una infección grave con instauración aguda y curso fluctuante.
- c) Debut de un episodio psicótico agudo (esquizofrenia tardía del anciano), pues tiene alucinaciones.
- d) Episodio de depresión grave debido a la hospitalización en urgencias, con sintomatología psicótica asociada.

2. ¿Cuál de las respuestas siguientes no es una de las circunstancias especiales que deben tenerse en consideración a la hora de evaluar a un paciente anciano en el servicio de urgencias?

- a) La probabilidad más alta de manifestarse las enfermedades agudas de forma atípica.
- b) La posible falta de colaboración del paciente durante la anamnesis a causa del deterioro cognitivo.
- c) La concurrencia de una o varias enfermedades crónicas que pueden descompensarse durante un proceso agudo.
- d) El riesgo más bajo de interacciones y reacciones adversas con el tratamiento inmediato en el servicio de urgencias.

3. Señale la afirmación correcta sobre la valoración geriátrica integral adaptada a urgencias (VGI-SU):

- a) Es una herramienta con la que se valoran aspectos exclusivamente clínicos.
- b) Es una herramienta diagnóstica que requiere hacer pruebas complementarias muy costosas.
- c) Es una herramienta diagnóstica con la que se valoran aspectos clínicos, funcionales, mentales y sociales.
- d) Es una herramienta que no puede aplicarse en el servicio de urgencias en ningún caso.



- 4. Señale la afirmación falsa sobre la valoración del síndrome confusional agudo (o delirium) en el servicio de urgencias:**
- a) Con el Confusional Assessment Method (CAM) se miden el nivel de la conciencia, la inatención, las posibles comorbilidades y el inicio de los síntomas; es un método fiable para diagnosticar el delirium.
 - b) El delirium con síntomas mixtos de hiperactividad e hipoactividad es la presentación clínica más frecuente.
 - c) En el síndrome confusional agudo —a diferencia de la psicosis—, la memoria está alterada.
 - d) El síndrome confusional agudo es un trastorno de causa orgánica que reduce la probabilidad de supervivencia al cabo de un año desde el diagnóstico.
- 5. Señale la afirmación falsa sobre el tratamiento del síndrome confusional agudo en los ancianos:**
- a) No hay pruebas concluyentes de que el uso de antipsicóticos reduzca la gravedad o la duración de los episodios.
 - b) No existe un consenso definitivo sobre la selección de antipsicóticos, aunque son preferibles los atípicos.
 - c) Se reserva el uso de antipsicóticos y otros medicamentos sedantes para el tratamiento de la agitación grave.
 - d) Las benzodiacepinas se indican como el tratamiento de primera elección.
- 6. ¿Qué tratamiento es el más indicado en el caso clínico descrito?**
- a) 0,5-5 mg de haloperidol por la vía intravenosa, repitiendo la dosis entre media hora y dos horas después.
 - b) 50-100 mg de tiaprida por la vía intravenosa, repitiendo la dosis entre media hora y dos horas después.
 - c) 0,5-2,5 mg de midazolam por la vía intravenosa. Dosis de ajuste: 0,5-1 mg cada 10-15 minutos.
 - d) 2,5-5 mg de olanzapina por la vía intramuscular, repitiendo la dosis entre media hora y cuatro horas después.

- 7. Señale la afirmación correcta sobre los problemas relacionados con la terapia del anciano:**
 - a) Los factores identificados en relación con problemas de cumplimiento terapéutico son aquellos que no dependen del tratamiento ni del paciente.
 - b) La polifarmacia es el factor de riesgo más importante en la aparición de efectos adversos a medicamentos.
 - c) El problema principal de las interacciones es que son predecibles y conducen siempre a la aparición de efectos adversos.
 - d) Aunque las reacciones adversas a medicamentos son más frecuentes en este grupo de población, la gravedad es menor en comparación con los pacientes más jóvenes.

- 8. ¿Cuál de las siguientes alteraciones metabólicas origina con menos frecuencia manifestaciones clínicas por afectación del sistema nervioso central primariamente?**
 - a) Amonio sérico de 300 micromol/L.
 - b) Glucosa sérica de 15 mg/dL.
 - c) Potasio sérico de 4,2 mEq/L.
 - d) Hipercapnia con PCO₂ de 70 mmHg.

- 9. Plántese el caso de un hombre de 34 años a quien se ha diagnosticado otitis media hace cinco días, sin otros antecedentes, que debuta con fiebre de 39 °C, cefalea, síndrome confusional y rigidez de la nuca. Se le hace una punción lumbar, cuyo resultado sugiere meningitis bacteriana. ¿Cuál de los siguientes sería el mejor tratamiento antibiótico empírico?**
 - a) Ceftriaxona y vancomicina.
 - b) Cefotaxima y ampicilina.
 - c) Moxifloxacino y vancomicina.
 - d) Meropenem y ampicilina.

- 10. Señale la afirmación falsa en relación con el examen de las pupilas de un paciente en coma:**
 - a) La miosis reactiva a la luz se relaciona con una lesión en el diencefalo.
 - b) La midriasis unilateral o anisocoria con reflejo directo negativo e indirecto conservado se relaciona con una lesión en el nervio óptico.
 - c) La midriasis bilateral no reactiva se relaciona con la muerte cerebral.
 - d) La midriasis bilateral reactiva se relaciona con la herniación uncal.



11. **En el caso de un paciente en tratamiento anticoagulante y antiagregante que presenta lenguaje incoherente, pero sin otras manifestaciones clínicas asociadas, y una lesión hiperdensa en forma de medialuna en la imagen de la tomografía computarizada (TC) craneal, ¿cuál es el diagnóstico más probable?**
- a) Hemorragia subaracnoidea.
 - b) Hematoma intraparenquimatoso.
 - c) Hematoma epidural.
 - d) Hematoma subdural.
12. **¿Cuál es la medida menos aceptada respecto al tratamiento de la hipertensión intracraneal en el servicio de urgencias?**
- a) Elevar la cabeza del paciente y mantenerla centrada.
 - b) Drenar el líquido cefalorraquídeo por medio de un drenaje lumbar.
 - c) Hiperventilación moderada.
 - d) Glucocorticoides, en algunas circunstancias.
13. **¿En qué estado se encuentra un paciente en coma rígido con los miembros superiores en extensión, aproximación y rotación interna y los miembros inferiores en extensión?**
- a) Estado prostrático.
 - b) Rigidez de decorticación.
 - c) Rigidez de descerebración.
 - d) Síndrome conversivo.
14. **En el caso de un paciente que acude a urgencias y en la exploración presenta habla fluente, mala comprensión del lenguaje, incapacidad para la repetición y disnomia, semiológicamente presenta un cuadro compatible con...**
- a) ...afasia de Broca.
 - b) ...afasia de conducción.
 - c) ...afasia transcortical sensitiva.
 - d) ...afasia de Wernicke.

15. Señale la afirmación falsa respecto al estupor:

- a) Es una alteración de la conciencia.
- b) Supone un estado reversible por estímulos moderados.
- c) Se utiliza este término en los estados de mutismo y de reducción de la actividad motora.
- d) En el ámbito de la neurología es un estado que precede al coma.

16. Existen varios términos semiológicos que tienen en cuenta el patrón respiratorio de un paciente en coma. Si se observa que en un paciente, tras un periodo de apnea, se producen respiraciones que aumentan progresivamente de amplitud y frecuencias y luego disminuyen progresivamente hasta otro episodio de apnea, ¿a qué patrón corresponde?

- a) Taquipnea.
- b) Platipnea.
- c) Respiración de Kussmaul.
- d) Respiración de Cheyne-Stokes.

17. Señale la respuesta incorrecta sobre los cuidados iniciales en el abordaje de un paciente en coma:

- a) Mantener la permeabilidad de la vía aérea.
- b) Vigilar la frecuencia respiratoria, el patrón de ventilación y los signos de hipoxemia.
- c) Mantener una presión arterial media por encima de 70 mmHg.
- d) Está contraindicado el uso de labetalol y nitroprusiato en todos los casos.

18. Señale la afirmación correcta sobre el líquido cefalorraquídeo:

- a) El líquido cefalorraquídeo normal es claro, transparente, tiene una presión de apertura de 5-20 cm H₂O y contiene un máximo de 5 células/mm³, que habitualmente son mononucleares.
- b) La proporción de glucorraquia respecto a la glucemia capilar es del 100 % y tiene 50-100 mg/dL de proteínas.
- c) Un perfil linfocitario con glucorraquia normal orienta al diagnóstico de meningitis de origen bacteriano.
- d) Un perfil leucocitario polimorfonuclear con glucorraquia disminuida orienta al diagnóstico de meningitis de origen vírico.

19. **Plantéese el caso de una joven de 20 años que acude al servicio de urgencias porque, después de levantarse y mirarse al espejo, ha notado debilidad en toda la mitad derecha de la cara (incluida la frente) al cerrar el párpado y al sonreír. La afectación está acompañada de disgeusia (sensación de sabor metálico de los alimentos), hiperacusia y dolor mastoideo ipsilateral. En la exploración no se evidencia déficit de la fuerza ni déficit sensitivo en las extremidades ni alteraciones del habla ni del lenguaje.**

Señale la afirmación correcta respecto a este caso:

- a) El diagnóstico más probable es una placa desmielinizante en la hemiprotuberancia contralateral y la exploración complementaria más necesaria es una resonancia magnética craneal.
- b) Los corticoides por la vía oral son de elección en el tratamiento de esta paciente.
- c) Debe ser considerada la fibrinólisis endovenosa si el tiempo de evolución es inferior a tres horas.
- d) Lo más probable es que el cuadro sea irreversible.

20. **Señale la afirmación correcta sobre las crisis epilépticas postraumáticas:**

- a) Son habituales inmediatamente después de un traumatismo craneal.
- b) Las lesiones penetrantes y la gravedad de la lesión son factores que favorecen estas crisis.
- c) Está indicado el tratamiento anticomitial profiláctico.
- d) Tras un par de años de riesgo más alto, los pacientes con lesiones graves tienen el mismo riesgo que la población general.

Preguntas de reserva

21. **Señale la afirmación falsa sobre los tratamientos específicos del coma reversible:**

- a) La dextrosa se utiliza en los casos de coma hipoglucémico.
- b) La tiamina se utiliza en los casos de encefalopatía de Wernicke.
- c) La rifampicina se utiliza en los casos de encefalopatía hepática.
- d) La ventilación mecánica se utiliza en los casos de encefalopatía hipercápica.

- 22. ¿Cuál de las respuestas siguientes no es un tipo de síndrome lacunar?**
- a) Síndrome motor puro.
 - b) Hemiparesia atáxica.
 - c) Torpeza en las manos y disartria.
 - d) Hemiplejia izquierda.
- 23. ¿Cuál de las respuestas siguientes es uno de los objetivos del control de los signos vitales en los casos de ictus agudo?**
- a) Tensión arterial por debajo de 185/105 mmHg.
 - b) Temperatura por debajo de 38 °C.
 - c) Glucemia por debajo de 170 mg/dL.
 - d) Saturación de oxígeno por encima del 93 %.
- 24. En el servicio de urgencias, ¿cuál es la actitud menos adecuada en un caso de hemorragia subaracnoidea?**
- a) Iniciar un tratamiento anticomitial preventivo.
 - b) Si el cuadro es muy sugestivo y el resultado de la TC craneal es normal, hay que hacer una punción lumbar.
 - c) Si se confirma la hemorragia, hay que solicitar una angiotomografía computarizada craneal con carácter urgente.
 - d) Hay que corregir las posibles alteraciones de la coagulación.

Caso 7

Un hombre de 67 acude al servicio de urgencias por fiebre de 38,5 °C desde hace un día acompañada de malestar general, dolor abdominal de tipo cólico en el flanco derecho, náuseas, algún vómito y molestias urinarias leves en forma de disuria y síndrome miccional. Refiere que hace dos días se le hizo una resección transuretral de la próstata, pero sin incidencias posteriores.

Antecedentes patológicos: diabetes *mellitus* de tipo 2, hipertensión arterial, dispepsia gástrica, gonartrosis. Cólicos nefríticos en la juventud. Sin alergias medicamentosas conocidas. No fumador.

Tratamiento: 850 mg de metformina cada 12 horas; 40/25 mg de olmesartán/hidroclorotiazida cada 24 horas; 20 mg de omeprazol cada 24 horas; paracetamol a demanda.

EXPLORACIÓN FÍSICA

- Constantes vitales: tensión arterial, 80/40 mmHg; frecuencia cardiaca, 120 lpm; frecuencia respiratoria, 30 rpm; saturación de oxígeno, 94 %; temperatura, 38,7 °C.
- Glucemia capilar, 320 mg/dL; cetonemia, 1,3; puntuación en la escala de coma de Glasgow, 13 (O = 4, V = 4, M = 5); peso, 70 kg.
- Mal aspecto general, hipoperfundido, sudoroso; puntuación en la EVA, 8/10.
- Auscultación cardiaca: taquicárdico, soplo sistólico aórtico mitral II/VI.
- Auscultación respiratoria: murmullo vesicular conservado sin ruidos añadidos.
- Abdomen: blando depresible sin signos de irritación peritoneal; puño percusión lumbar derecha débil positiva, izquierda negativa; pulsos periféricos presentes y simétricos.

1. Señale la respuesta correcta según las escalas de valoración de la sepsis:

- a) Con la escala quick SOFA < 2.
- b) Con la escala MEWS < 5 puntos.
- c) Con la escala NEWS 2 media: 6 puntos.
- d) Con la escala quick SOFA > 2.

Resultados de la analítica:

- Hemograma: leucocitosis, 25.000 (neutrofilia, 85 %, plaquetas, 150.000/mm³).
- Coagulación: tiempo de protrombina, 70 %; INR, 1,2.
- Bioquímica: creatinina, 7,2 mg/dL; urea, 80; ionograma, normal; bilirrubina total, 2,3; PCR, 23; procalcitonina, 10 ng/mL.
- Gasometría arterial AA: pH, 6,9; pO₂, 57; pCO₂, 24; HCO₃, 12; EB, -23; ácido láctico, 8,0 mmol/L.
- Sedimento: nitritos, positivo con abundantes microorganismos y leucocituria.
- Hemocultivos: pendientes de resultados.

2. ¿Hacia qué diagnóstico orientan los resultados de esta analítica?

- a) Cetoacidosis diabética con fiebre.
- b) Diverticulitis aguda.
- c) Sepsis de origen renal.
- d) Cólico biliar complicado.

3. Señale la respuesta correcta de acuerdo con los datos de las gasometría:

- a) Acidemia metabólica e insuficiencia respiratoria.
- b) Acidosis metabólica e insuficiencia respiratoria normocápnica.
- c) Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria compensadora.
- d) Acidemia láctica.

4. Señale la afirmación falsa sobre la procalcitonina:

- a) Es un biomarcador utilizado para valorar la gravedad y la mortalidad en los procesos sépticos.
- b) Ayuda a distinguir la sepsis de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) no infeccioso gracias que alcanza una sensibilidad del 98 % y una especificidad de más del 90 % si los valores son superiores a 10 ng/mL.
- c) No se eleva en los casos de *shock* cardiogénico o de carcinoma de pulmón.
- d) Se recomienda hacer una nueva determinación a las 8-12 horas y a las 24 horas para comprobar la variación y estimar la mejoría o la progresión de la infección.

5. **Después de trasladar al paciente al aérea de críticos con monitorización no invasiva, hay que iniciar el tratamiento de resucitación con...**
 - a) ...500 mL de suero fisiológico en la primera hora.
 - b) ...suero fisiológico a ritmo de 30 mL/kg en las primeras tres horas.
 - c) ...500 mL de lactato de Ringer en la primera hora.
 - d) ...500 mL de Isofundin® en la primera hora.

6. **Dados los valores de la gasometría, señale la respuesta correcta sobre el tratamiento que debe administrarse en la fase de resucitación:**
 - a) Perfusión de bicarbonato 1/6 M a través de una vía periférica.
 - b) Perfusión de bicarbonato 1M (a una dosis de 1 mEq/kg).
 - c) No hay que añadir bicarbonato.
 - d) Hay que añadir una perfusión de suero glucosado al 10 % con insulina.

7. **Señale la afirmación correcta sobre el tratamiento antibiótico en el caso clínico descrito:**
 - a) Debe iniciarse lo antes posible: se recomienda antes de la primera hora desde el diagnóstico, hasta un máximo de tres horas.
 - b) La dosis inicial debe estar ajustada a la función renal.
 - c) La dosis inicial debe ser plena.
 - d) Las respuestas a) y c) son correctas.

8. **Bajo la sospecha diagnóstica y el foco de infección, ¿cuál es el tratamiento antibiótico adecuado en este caso clínico?**
 - a) 4 g de piperacilina tazobactam cada 8 horas +/- 15 mg/kg de amikacina en una dosis única diaria.
 - b) 2 g de piperacilina tazobactam cada 12 horas +/- 15 mg/kg de amikacina en una dosis única diaria.
 - c) 1 g de meropenem cada 8 horas +/- 15 mg/kg de amikacina en una dosis única diaria.
 - d) 2 g de ceftriaxona cada 24 horas +/- 15 mg/kg de amikacina en una dosis única diaria.

9. **¿Cuál de las respuestas siguientes no es una de las variables dinámicas que deben revisarse tras la resucitación inicial, según las recomendaciones de las guías internacionales de sepsis, y que indicarían fracaso?**
- a) Diuresis < 50 mL/h.
 - b) Presión arterial media > 65 mmHg.
 - c) Aclaramiento de lactato < 20 %.
 - d) Insuficiencia respiratoria con $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 300$ (en ausencia de neumonía).
10. **Señale la afirmación falsa de acuerdo con las guías Surviving Sepsis Campaign de 2021:**
- a) La sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal, causada por una respuesta inadecuada del huésped a una infección documentada clínica y/o microbiológicamente.
 - b) La sepsis grave se mantiene en la actualidad como definición.
 - c) La sepsis es dependiente del tiempo y, por lo tanto, es una emergencia médica.
 - d) La sepsis es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo.
11. **Una de las medidas para reducir la incidencia de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria es la higiene de manos. Señale en qué momento es incorrecta:**
- a) Antes de tocar al paciente.
 - b) Antes de llevar a cabo una tarea limpia/aséptica.
 - c) Antes del riesgo de exposición a líquidos corporales.
 - d) Después del contacto con el paciente y/o su entorno.

Tras la resucitación adecuada, al cabo de tres horas el paciente presenta estos parámetros:

- Presión arterial media: 55 mmHg; frecuencia cardiaca, 110 lpm; frecuencia respiratoria, 24 rpm; saturación de oxígeno con gafas nasales a 2 litros, 97 %; temperatura, 37,7 °C
- Diuresis, 0 mL; glucemia, 270 mg/dL; cetonemia, 0,8 mmol/L; ácido láctico, 3,5 mmol.
- Gasometría venosa: pH, 7,2; HCO₃, 22; EB, -5.

12. ¿En qué situación está este caso clínico?

- a) Evolución lenta, pero favorable; el aclaramiento del ácido láctico es correcto.
- b) La situación evoluciona a *shock* séptico.
- c) Persistencia de la cetoacidosis diabética.
- d) Hipoperfusión asociada a sepsis.

13. Si se decide administrar una droga vasoactiva, ¿cuál es la de elección, entre las siguientes?

- a) Dado que no se dispone de una vía central, no puede administrarse.
- b) Dobutamina.
- c) Vasopresina.
- d) Noradrenalina por una vía periférica.

14. ¿Cuál de las respuestas siguientes es una medida terapéutica adicional que puede tomarse en consideración?

- a) Vitamina C por la vía endovenosa.
- b) Inmunoglobulinas por la vía endovenosa.
- c) Corticoesteroides (40 mg de metilprednisolona cada 8 horas).
- d) Insulina para corregir la hiperglucemia.

- 15. Por medio de una prueba diagnóstica por la imagen se observa una marcada hidronefrosis derecha, litiasis ureteroyuxtavesical renal derecha de 11 mm de diámetro y distensión de la vesícula biliar sin paredes engrosadas ni presencia de litiasis en su interior.**

¿Cuál de las opciones terapéuticas siguientes es correcta?

- a) Interconsulta al servicio de urología para valorar una nefrostomía derecha.
- b) Mantener la resucitación y administrar antibióticos como se han iniciado y esperar.
- c) Interconsulta al servicio de nefrología para hemodiálisis.
- d) Interconsulta al servicio de cirugía para una colecistectomía.

- 16. Si se sospechase una colecistitis aguda en este caso clínico, ¿cuál de las respuestas siguientes no es uno de los criterios diagnósticos según la guía de Tokio de 2018?**

- a) Signos locales: signo de Murphy o masa, dolor o defensa en el hipocondrio derecho.
- b) Signos sistémicos: fiebre de menos de 37,5 °C o PCR alta o leucocitosis por encima de 10.000 células/mm³.
- c) Imagen: edema de pared de más de 5 mm, vesícula distendida, signo de Murphy radiológico, líquido perivesicular, colelitiasis.
- d) Imagen: edema de pared de menos de 5 mm, vesícula distendida, signo de Murphy radiológico, líquido perivesicular, colelitiasis.

- 17. ¿Cuál de las respuestas siguientes no es uno de los criterios de gravedad para la colecistitis aguda de grado moderado?**

- a) Incremento de la leucocitosis de más de 18.000 células/mm³.
- b) Duración de los síntomas de más de 72 horas.
- c) Tiempo de protrombina INR < 1,5.
- d) Marcada inflamación local (colecistitis gangrenosa, absceso perivesicular, colecistitis enfisematosa).

- 18. En este caso clínico se podría sospechar una infección por un microorganismo multirresistente. ¿Cuál es la definición de multirresistente?**
- a) Ausencia de sensibilidad al menos a un antibiótico de tres o más familias consideradas de utilidad para el tratamiento de las infecciones producidas por cada una de las especies bacterianas consideradas.
 - b) Probabilidad alta de éxito terapéutico porque la exposición al agente está incrementada por el ajuste del régimen de dosificación por su concentración en lugar de la infección.
 - c) Ausencia de sensibilidad a todos los antibióticos de todas las familias habituales utilizadas en el tratamiento de la bacteria considerada.
 - d) Probabilidad alta de fracaso terapéutico incluso cuando hay incremento de la exposición.
- 19. En relación con los microorganismos multirresistentes hay que tener en cuenta a todos los siguientes, excepto uno. Señálelo:**
- a) *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina (SARM, MRSA por la denominación en inglés).
 - b) Enterobacteria productora de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) o de betalactamasas plasmídicas de tipo AmpC.
 - c) Enterobacteria productora de carbapenemasas (EPC).
 - d) *Pseudomona aeruginosa*.
- 20. En los programas PROA de los hospitales se incluye a los servicios de urgencias. ¿Cuál de las respuestas siguientes no es uno de los objetivos generales de dichos programas?**
- a) Registro de todos los microorganismos multirresistentes y creación de una base de datos.
 - b) Formación de un curso PROA básico dirigido a todos los adjuntos de los servicios de urgencias.
 - c) Mejoría del pronóstico de los pacientes con infecciones.
 - d) Reducción de la presión antibiótica y de los efectos adversos.

Preguntas de reserva

21. El paciente del caso clínico descrito recibe el alta tras superar su enfermedad pero regresa al servicio de urgencias tres días después con diarrea, tos, disnea y fiebre de 39 °C. Por medio de una radiografía del tórax se observa un derrame pleural derecho hasta el tercio medio y condensación en el lóbulo superior derecho (el resto, sin alteraciones). Se sospecha una neumonía intrahospitalaria.

Señale la afirmación correcta:

- a) La neumonía intrahospitalaria es la segunda causa de infección nosocomial y la que presenta una tasa de mortalidad más baja.
- b) No es probable que *Acinetobacter baumannii* sea el microorganismo responsable.
- c) Entre las medidas para reducir la incidencia de la neumonía intrahospitalaria están optimizar la higiene oral, elevar el cabecero de la cama y la deambulación precoz.
- d) La sospecha de microorganismos multirresistentes no tiene relación con la administración de antibióticos en los 90 días previos.

22. Señale la respuesta incorrecta en caso de que se hiciera una toracocentesis a este paciente:

- a) Los valores de la glucosa en el líquido pleural inferiores a 60 mg deben orientar a los diagnósticos de empiema, proceso neoplásico, tuberculosis o artritis reumatoide.
- b) No se recomienda extraer más de 1.000 mL de una vez en la toracocentesis para evitar el edema *ex vacuo* o por reexpansión pulmonar.
- c) El pH en el líquido pleural inferior a 7,20 puede verse en los casos de derrame pleural paraneumónico complicado o empiema, rotura esofágica o proceso neoplásico.
- d) Un coeficiente de LDH pleural / LDH plasma superior a 0,6 es un trasudado.



- 23. En el caso de un paciente seropositivo al VIH con carga detectable o desconocida y con factores de riesgo, ¿en qué situación no está indicada la profilaxis postexposición no ocupacional con antirretrovirales?**
- a) Relaciones anales y/o vaginales sin preservativo.
 - b) Intercambio de jeringuillas con consumidores de drogas por la vía parenteral.
 - c) Mordedura humana con rotura de la piel o sangrado.
 - d) Pinchazo o erosión superficial con una aguja u otro objeto punzante abandonado que no ha estado en contacto con sangre recientemente.
- 24. Señale la afirmación correcta sobre las infecciones de transmisión sexual:**
- a) Las lesiones de origen sifilítico (sífilis primaria) son muy dolorosas.
 - b) Se recomienda hacer pruebas serológicas para detectar los virus de la hepatitis B, de la hepatitis C y de la inmunodeficiencia humana.
 - c) Las infecciones de transmisión sexual con una tasa más alta de incidencia son las causadas por *Neisseria gonorrhoeae*, según los datos de vigilancia epidemiológica de 2019.
 - d) El tratamiento empírico de elección consiste en 250 mg de ceftriaxona por la vía intramuscular y 1 g de azitromicina en dosis única por la vía oral.



G CONSELLERIA
O SALUT
I SERVEI SALUT
B ILLES BALEARS
/

